

Vignette clinique N°1

- Mme D., née en 1936, vient vous consulter car elle a présenté des pertes vaginales de sang noir.
- L'interrogatoire de Mme D montre que ces pertes sont survenues à plusieurs reprises au cours des 4 derniers mois sans cause déclenchant évidente.
- La patiente n'a pas d'autres plaintes sauf une tension pelvienne lors des pertes.

Vignette clinique N°1

- Ses antécédents sont les suivants :
 - 2ème geste, primipare (1 IG et 1 césarienne pour 1 gros bébé),
 - appendicectomie à l'âge de 9 ans,
 - fibromes utérins traités par progestatifs puis ménopause à 54 ans,
 - diabète non insulino-dépendant depuis 15 ans traité par anti-diabétique oral et régime hypo-glucidique.
- Mme D mesure 158 cm et pèse 81 kg.

Question 1:

Quelles sont les principales étiologies des métrorragies post-ménopausiques ?

1. cancer endométrial,
2. fibrome utérin,
3. hyperplasie endométriale,
4. atrophie endométriale,
5. Endométriose pelvienne.

Les principales étiologies des métrorragies post-ménopausiques :

- Cancer endométrial,
- cancer du col utérin,
- atrophie endométriale,
- hyperplasie endométriale,
- cervicite-vaginite,
- cancer de vulve,
- prolapsus ulcéré,
- tumeur ovarienne.

Question 2:

A l'examen, le vagin et le col utérin sont sans lésion visible; le toucher vaginal semble normal bien que peu informatif du fait de l'obésité.

Vous réalisez un frottis du col utérin car le précédent remonte plus de 2 ans.

Quelles explorations complémentaires proposez-vous ?

Question 2:

Quelles explorations complémentaires proposez-vous ?

1. Cystoscopie.
2. Colposcopie.
3. Ultrason endovaginal.
4. Scanner abdomino-pelvien.
5. Biopsie endométriale.

Quelles explorations complémentaires proposez-vous ?

Frottis cervico-utérin avec étude cytologique,

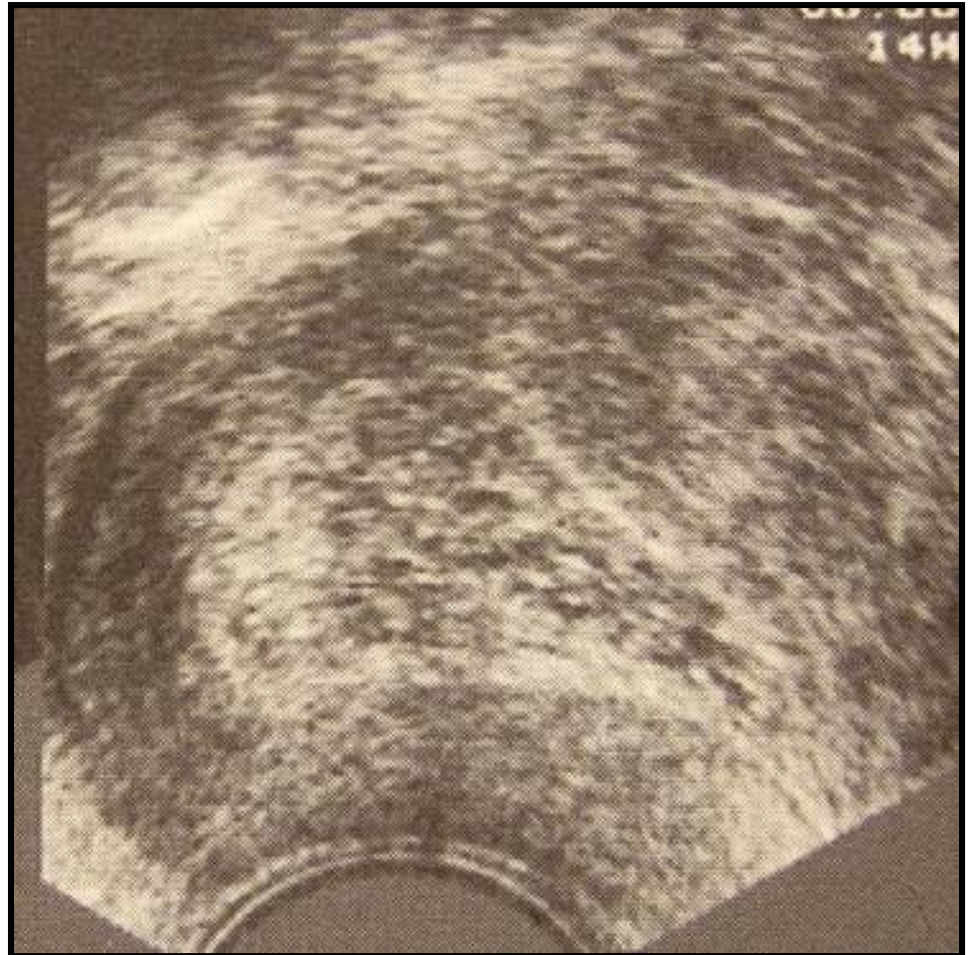
US (échographie) endovaginal,

Biopsie endométriale à la pipelle de Cornier avec étude histologique.



Le rapport de l'US endovaginal

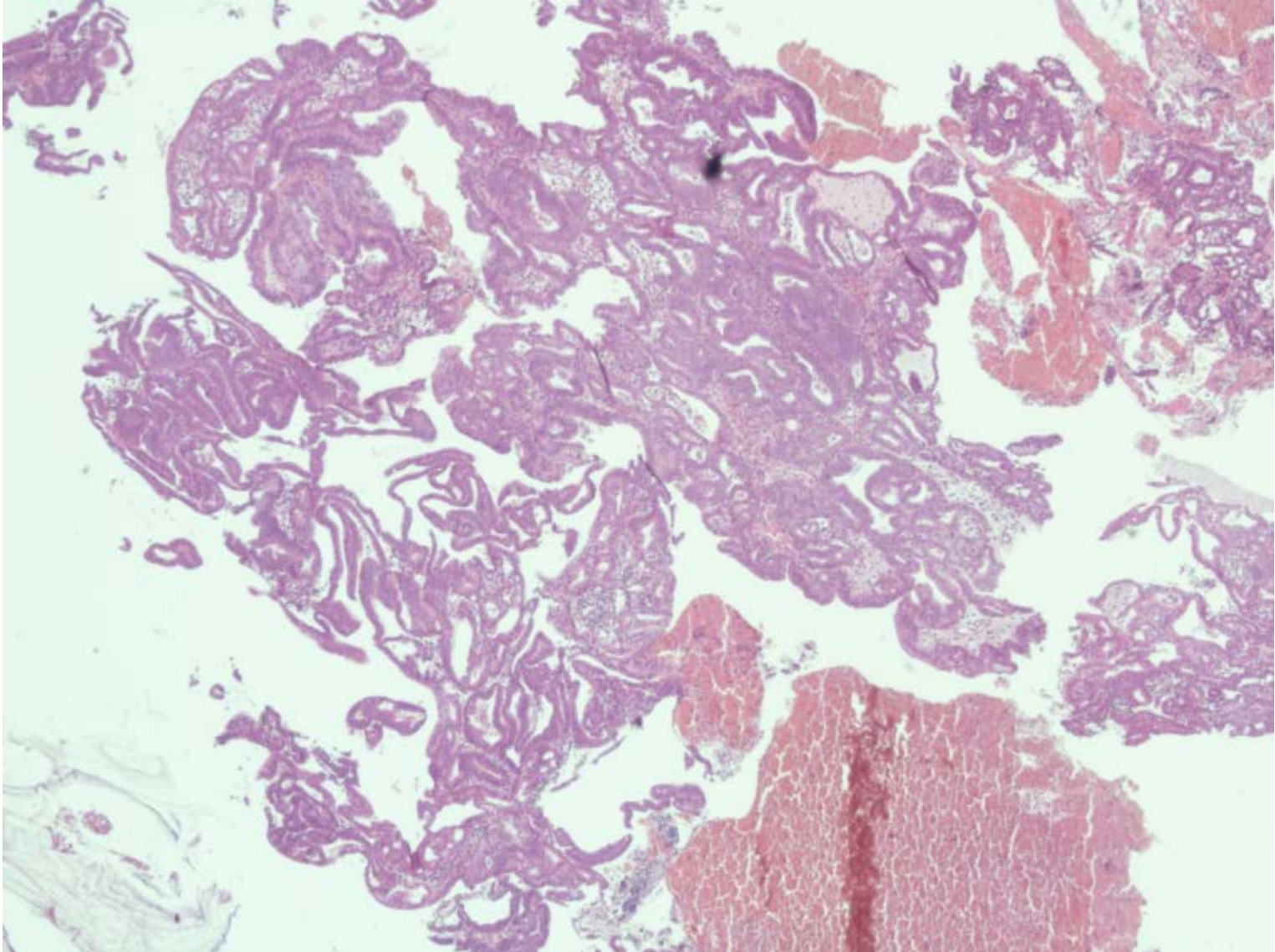
- Retrouve un endomètre anormalement épaissi à 14 mm,
- et 2 myomes calcifiés intramuraux de 25 et 34 mm.

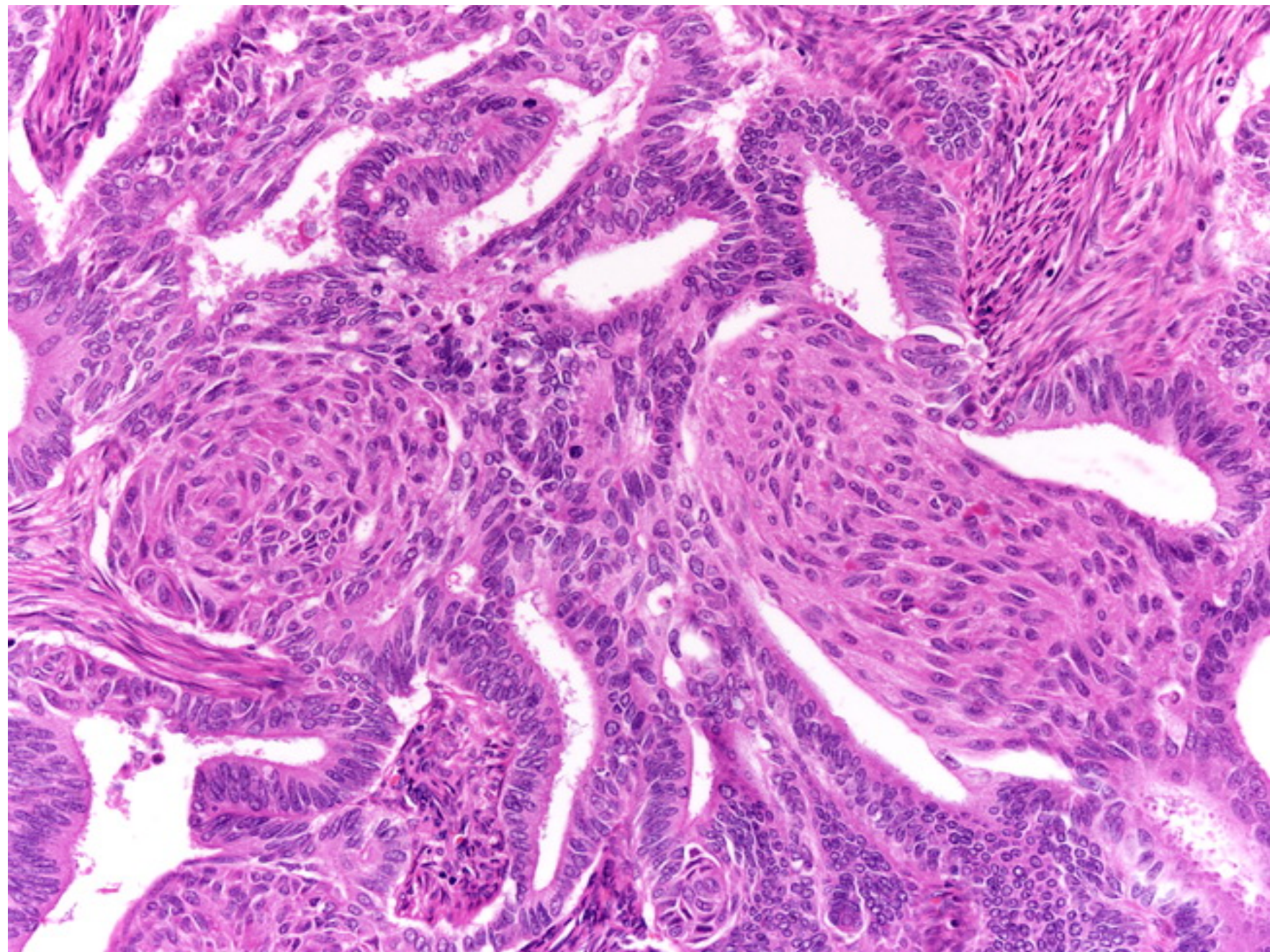


Question 3

- Quelles sont les principales causes d'endomètre épaissi après la ménopause:
 1. Rétention trophoblastique.
 2. Cancer endométrial
 3. Polype endométrial
 4. Atrophie endométriale
 5. Cloison utérine

La biopsie endométriale montre les aspects anatomopathologiques suivants:





Question 4:

Quels sont les aspects anatomopathologiques présents? (plusieurs réponses correctes)

1. Glandes endométriales atrophiques
2. Architecture glandulaire complexe
3. Métaplasie squameuse
4. Noyaux atypiques
5. Hyperplasie endométriale non atypique

Question 5:

Au terme du bilan paraclinique, il existe un diagnostic d'adénocarcinome endométroïde de grade 1.

Quels sont les facteurs de risque de cancer endométrial que présente Mme D. ?

Question 5:

Quels sont les facteurs de risque de cancer endométrial que présente Me D. ?

1. Obésité (BMI élevé).
2. Ménopause précoce.
3. Antécédent de gros bébés.
4. Multiparité.
5. Antécédent de polypes utérins.

Epidémiologie et Histogénèse du Cancer endométrial

- Cancer gynécologique pelvien le plus fréquent en Suisse.
- Incidence = 16,2/100 000 femmes-an
- Mortalité = 3,2/100 000 femmes-an (survie = 80 %).
- L'âge moyen lors du diagnostic se situe à 68 ans.
- Histoire naturelle: cancer hormono-induit.
- Femmes à risque: âge élevé, puberté précoce, fécondité faible ou nulle, ménopause tardive, obésité (+ hypertension, diabète), traitement par tamoxifène.
- Formes héréditaires: Sd de Lynch II (HNPCC).

Questions 6:

- Quelles explorations complémentaires proposez-vous pour mieux apprécier les modalités thérapeutiques de cette tumeur ?
 1. Une IRM pelvienne.
 2. Un typage HPV.
 3. Un PET-scan.
 4. Une cystoscopie.
 5. Un hystéroscopie avec curetage.

Recommandations pré-thérapeutiques

Bilan standard

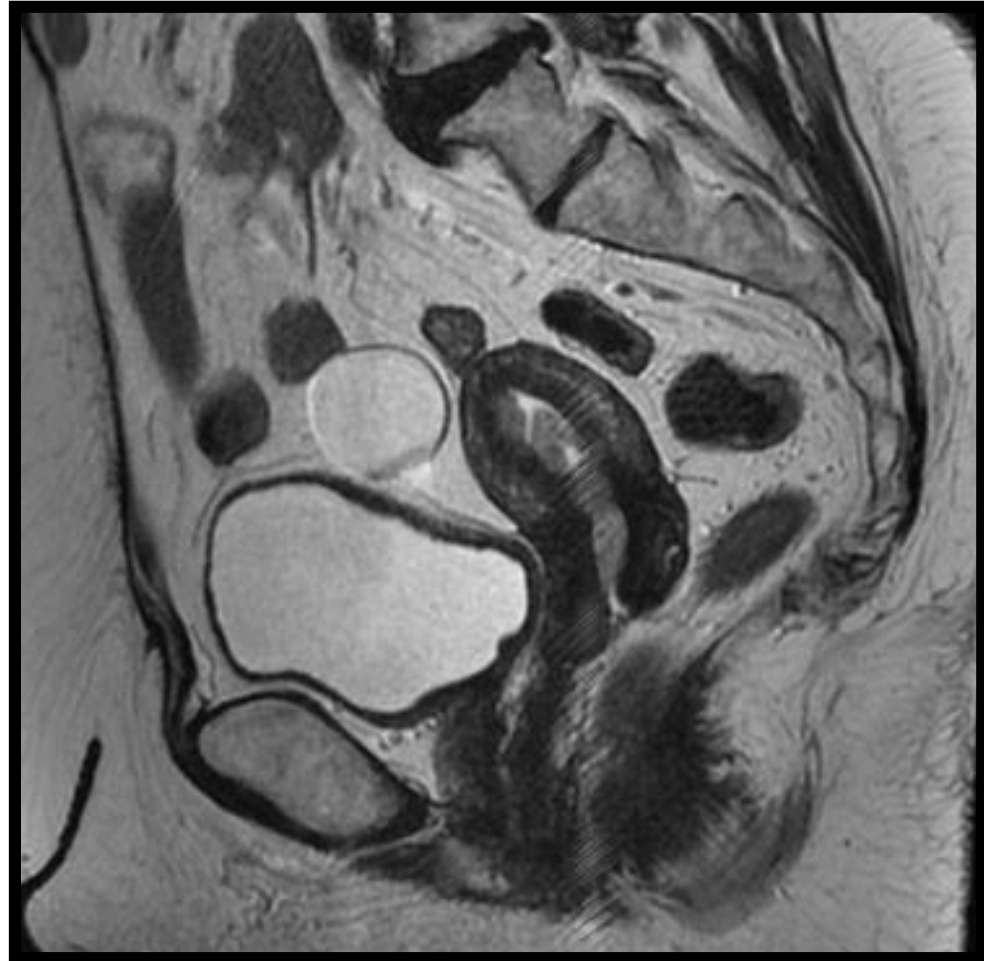
- US endo-vaginal
- Biopsie endomètre à la pipelle de CORNIER
- Si échec ou impossibilité d'utilisation: hystéroscopie (notant la dimension de la lésion et sa localisation) avec curetage dirigé.
- IRM pour apprécier l'envahissement en profondeur et l'extension régionale.

A discuter

- Si suspicion de stade avancé ($\geq$ II) : TEP-Scan ou TDM TAP, CA 125
- Bilan d'opérabilité car patientes souvent fragiles, âgées...

IRM pelvienne

Au terme des explorations, l'extension du cancer endométrial semble limitée au corps utérin mais envahit environ 30% du myomètre.



Question 7:

Quel est le stade FIGO de la lésion ?

1. Stade IA
2. Stade IC
3. Stade II
4. Stade III
5. Stade inconnu

Cancers de l'endomètre

Stadification FIGO 2014

- Stade I : tumeur limitée au corps utérin
 - IA: invasion < à la moitié du myomètre
 - IB: invasion $\geq$ à la moitié du myomètre.
- Stade II : invasion du stroma cervical.
- Stade III : extension locale et/ou régionale de la tumeur.
 - III A : atteinte de la séreuse utérine ou des annexes.
 - III B : atteinte vaginale ou paramétriale.
 - III C : métastases ganglionnaires.
 - IIIC1: métastases ganglionnaires pelviennes.
 - IIIC2: métastases ganglionnaires lombo-aortiques.
- Stade IV
 - IVA : base vésicale et/ou paroi intestinale.
 - IVB : métastases à distances.

La cytologie péritonéale positive ne modifie pas le stade.

Question 8:

Il s'agit donc a priori d'un cancer
endométrial grade 1 de stade IA.
Quelle(s) modalit  (s) th  rapeutique(s)
est(sont) conseill  e(s) ?

Question 8:

Quelle modalité thérapeutique est conseillée ?

1. Une ablation de la lésion par curetage
2. Une hystérectomie totale non conservatrice.
3. Une hystérectomie totale conservatrice.
4. Une chimiothérapie première.
5. Une radiothérapie pelvienne.

Modalités thérapeutiques d'un cancer endométrial stade IA

Le traitement initial repose sur une hystérectomie totale non conservatrice avec cytologie péritonéale de préférence par laparoscopie.

Les traitements adjuvants (curiethérapie, radiothérapie externe, voire chimiothérapie) seront basés sur les données histologiques définitives de la pièce d'hystérectomie et proposés après avis d'un comité pluridisciplinaire compétent en cancérologie gynécologique.

Examen anatomopathologique de la pièce opératoire:

- Adénocarcinome endométrial gr 1
- Étendu sur 26 mm
- Avec invasion du myomètre <50%
- Sans atteinte du col utérin ni des annexes
- Absence d'embolies lympho-vasculaires
- Cytologie péritonéale sans particularités

Question 9:

Au vu des résultats histologiques définitifs, quel traitement adjuvant préconisez-vous ?

1. Aucun.
2. Curages ganglionnaires pelviens et lombéo-aortiques.
3. Curiethérapie exclusive.
4. Radiothérapie pelvienne + curiethérapie.
5. Chimiothérapie.

Prise en charge, Stade I

- **Bas risque:**
 - Stade IA, sans envahissement du myomètre et grade 1 ou 2.
 - Stade IA grade 1.
- **Risque intermédiaire:**
 - Stade IA avec effraction myométriale et grade 2.
 - Stade IB grade 1 ou 2.
- **Haut risque:**
 - Stade IA ou IB grade 3.
 - Type 2 histo.
- **Facteurs de mauvais pronostic:**
 - Emboles lympho-vasculaires
 - Age avancé (+ de 65 ans)

Prise en charge

- Type 1 histo et stade I:
 - **Bas risque** = HT non conservatrice + cyto
 - **Risque intermédiaire** = HT non conservatrice + cyto + curiethérapie (lympho pelvienne et LA peuvent être proposés dans certaines situations).
 - **Haut risque** = HT non conservatrice + cyto + curage pelvien (+/- LA dans certaines situations) + radiothérapie externe et curiethérapie.

si N+ suspecté à l'imagerie et/ou à l'extemporané faire un curage lombo-aortique.

Question 10:

Quelles sont les chances de survie sans récurrence à 5 ans au vu des résultats histologiques ?

1. > à 90%
2. Environ 75%
3. Environ 50%
4. Environ 35%
5. < à 15%

Vignette clinique N°2

- Madame G, 41ans, 3ème geste, 2ème pare (2 grossesses normales avec accouchements normaux à terme et une IG) est sous contraception par DIU au cuivre depuis son dernier accouchement il y a 4 ans.
- Elle vous consulte pour une asthénie s'aggravant. Votre bilan sanguin met en évidence une anémie ferriprive avec un taux d'Hb à 98 g/l.

Vignette clinique N°2

- La patiente n'a pas d'antécédents notables ni d'autres traitements en cours.
- A l'interrogatoire, la seule source de spoliation sanguine retrouvée correspond à des règles de plus en plus hémorragiques avec des caillots. De plus, les règles ont tendance à s'attarder durant 6 jours. Il n'y a pas de saignement en dehors des règles.

Question 1:

- Comment se dénomme la symptomatologie présentée par la patiente ?
 1. Des métrorragies
 2. Une spanioménorrhée
 3. Des rectorragies
 4. Des ménorragies
 5. Une aménorrhée

Question 2:

Quelles sont les 2 principales étiologies des ménorragies ?

1. Les fibromes utérins
2. L'atrophie endométriale
3. Les cancers de l'endomètre
4. La cervicite
5. L'adénomyose utérine

Principales étiologies des ménorragies:

- Fibromes utérins
- Adénomyose utérine
- Polype endométrial
- Hyperplasie endométriale
- Cause fonctionnelle
- Endométrite
- Pathologie de la grossesse (GEU, FCS...)
- Cancer endométrial

Question 3:

- Quels sont les éléments principaux de votre examen clinique ?
 1. Une palpation abdominale.
 2. Un examen au spéculum.
 3. Une palpation des aires ganglionnaires.
 4. Une analyse d'urine.
 5. Un toucher vaginal.

Principaux éléments de l'examen clinique

- Examen au spéculum: appréciation du col et recherche d'un polype sentinelle.
- Réalisation d'un frottis cervical, éventuellement d'une biopsie endométriale (pipelle de Cornier).
- Palpation abdominale: évaluation du volume utérin.
- TV: morphologie, volume, mobilité utérine, annexes.
- Examen général: pouls, TA, signes d'anémie.

Vignette clinique N°2

A l'examen:

- Le col est d'aspect normal ainsi que vagin, la vulve et l'anus.
- l'utérus est largement augmenté de taille remontant jusqu'à 2 travers de doigt sous l'ombilic.
- Il est indolore et il ne semble pas exister d'anomalie annexielle.
- La TA est à 95/65 mmHg et le pouls à 84 b/min.

Question 4:

Quel examen paraclinique préconisez-vous pour explorer les ménorragies ?

1. Une colposcopie.
2. Une recherche de papillomavirus humain.
3. Un dosage du CA 125.
4. Un ultrason gynécologique.
5. Un scanner pelvien.

Bilan paraclinique préconisé:

- US endovaginal: évaluation de la cavité utérine, du myomètre, de l'épaisseur endométriale, des annexes, du pelvis.
- Frottis cervical et éventuelle biopsie endométriale (si métrorragies associées).
- Prélèvement bactériologique (+ mycoplasmes, chlamydiae) si clinique évocatrice.
- Biologie: formule sanguine, ferritine, B-HCG (ou test urinaire de grossesse).

L'examen US retrouve l'aspect
suivant:



Le CR de l'US note essentiellement les aspects suivants:

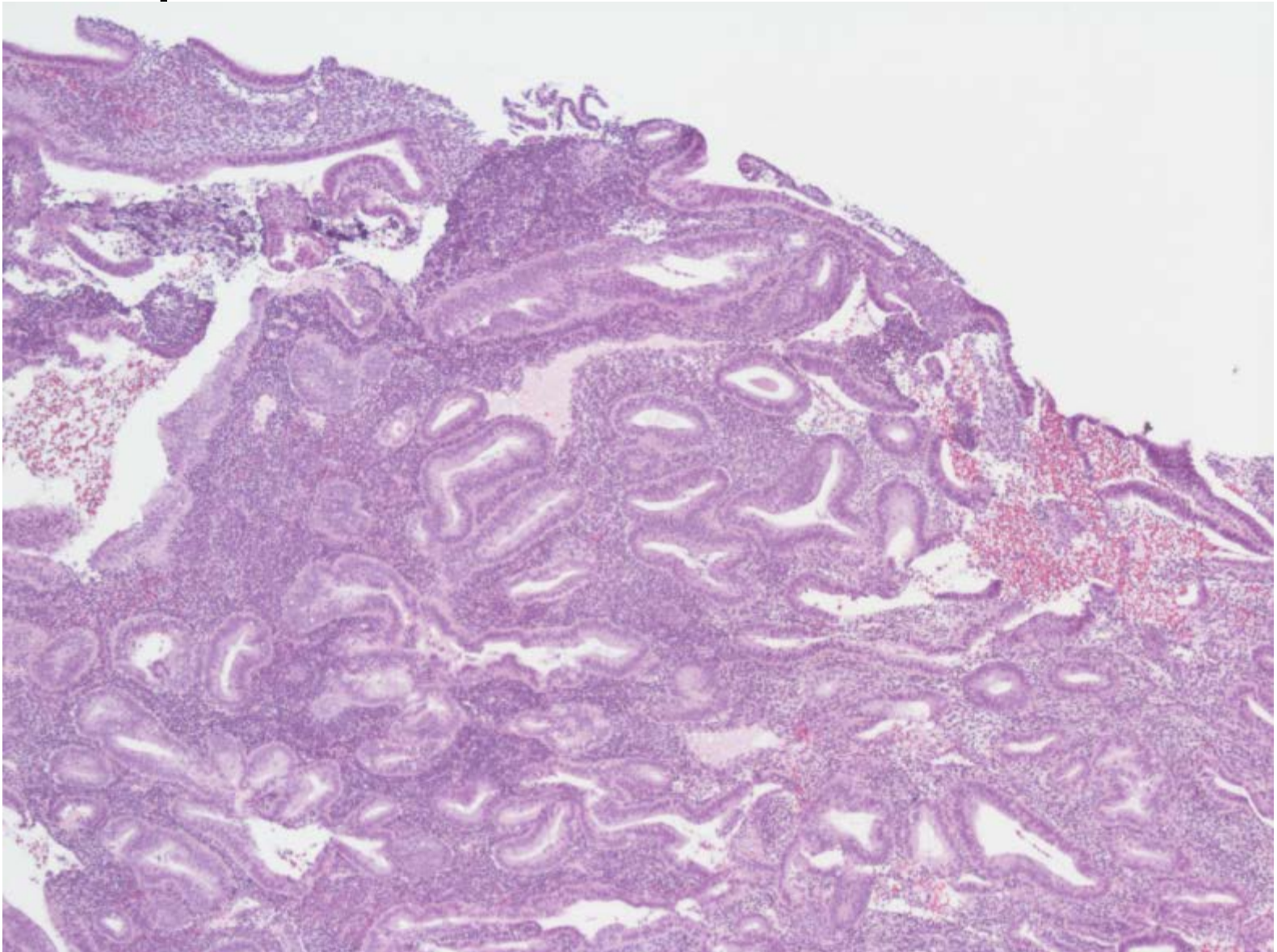
- un utérus porteur de 3 fibromes, 2 intramuraux de 8 et 4 cm et un sous-séreux de 11 cm situé au niveau de la corne utérine droite.
- Il existe aussi une image liquidienne cervicale de 2 cm évoquant un kyste de Naboth.
- L'endomètre est mesuré à 16 mm pour son épaisseur.
- L'ovaire droit est porteur d'un kyste du corps jaune de 21 mm.
- Il est noté la présence d'un petit épanchement liquidien du Douglas d'environ 50 cc.

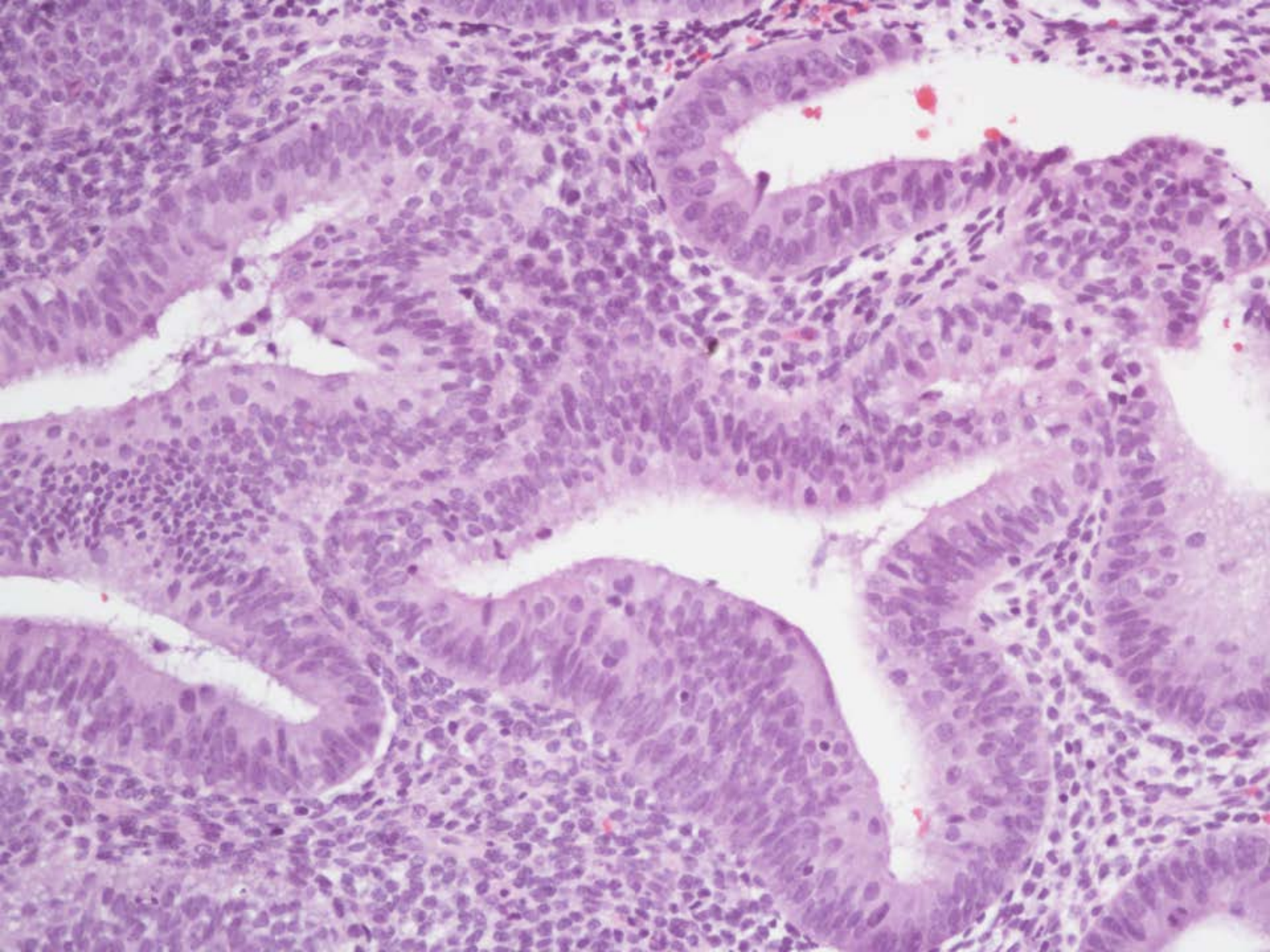
Question 5:

Parmi les éléments décrits à l'US lequel peut expliquer les saignements présentés par la patiente ?

1. Le fibrome sous-séreux de 11 cm.
2. Le kyste de Naboth de 2 cm.
3. L'endomètre de 16 mm d'épaisseur.
4. L'ovaire droit porteur d'un kyste du corps jaune de 21 mm.
5. L'épanchement liquidien du Douglas.

L'aspect anatomopathologique de la biopsie endométriale est celui-ci





Question 6:

Quel aspect anatomopathologique est présent sur cette biopsie ?

1. Atrophie glandulaire
2. Rapport glandes / stroma augmenté
3. Métaplasie squameuse
4. Noyaux arrondis et nucléolés
5. Atypies cytologiques et architecturales.

Question 7:

Quels traitements immédiats proposez-vous pour diminuer le flux menstruel ?

1. Prescription d'un anti-œstrogène: le tamoxifène.
2. Prescription d'un antifibrinolytique.
3. Ablation du DIU au cuivre.
4. Curetage hémostatique.
5. Hystérectomie en urgence.

Les principaux traitements en urgence pour la réduction du flux menstruel sont:

- Cyclokapron (ac. traxénamique) 500: 2-0-2.
- + éventuellement misoprostol (Cytotec).
- + éventuellement macroprogestatif (Farlutal 250 mg/j): risque thrombo-embolique un peu majoré.
- Penser au fer per os voire injectable.

Question 8:

Quel est le principal traitement médical qui peut être proposé à la patiente du fait des anomalies constatées ?

1. Anti-inflammatoires non stéroïdiens en période de règles.
2. DIU au lévonorgestrel.
3. Progestatif faiblement dosé per os 10 jours par mois.
4. Anti-œstrogène: le tamoxifène.
5. Ullipristal (Esmya).

Principaux traitements médicaux potentiellement efficaces:

- DIU au lévonorgestrel.
- Macroprogestatif (par ex Farluta 250mg/j).
- Agonistes de la LHRH (mais pas plus de 6-9 mois et effets secondaires ++).
- Esmya mais utilisation limitée du fait d'hépatites rares mais sévères...
- Traitement « au coup par coup » par antifibrinolytiques.

Question 9:

Malgré votre traitement médical, la patiente garde une anémie invalidante.

Quels sont les principaux traitements chirurgicaux qui peuvent être proposés à la patiente du fait des anomalies constatées ?

Question 9:

Quels sont les principaux traitements chirurgicaux qui peuvent être proposés à la patiente du fait des anomalies constatées ?

1. Curetage +/- thermocoagulation endométriale.
2. Résection endométriale hystéroscopique.
3. Myomectomies par laparoscopie.
4. Hystérectomie totale conservatrice.
5. Hystérectomie sub-totale non conservatrice.

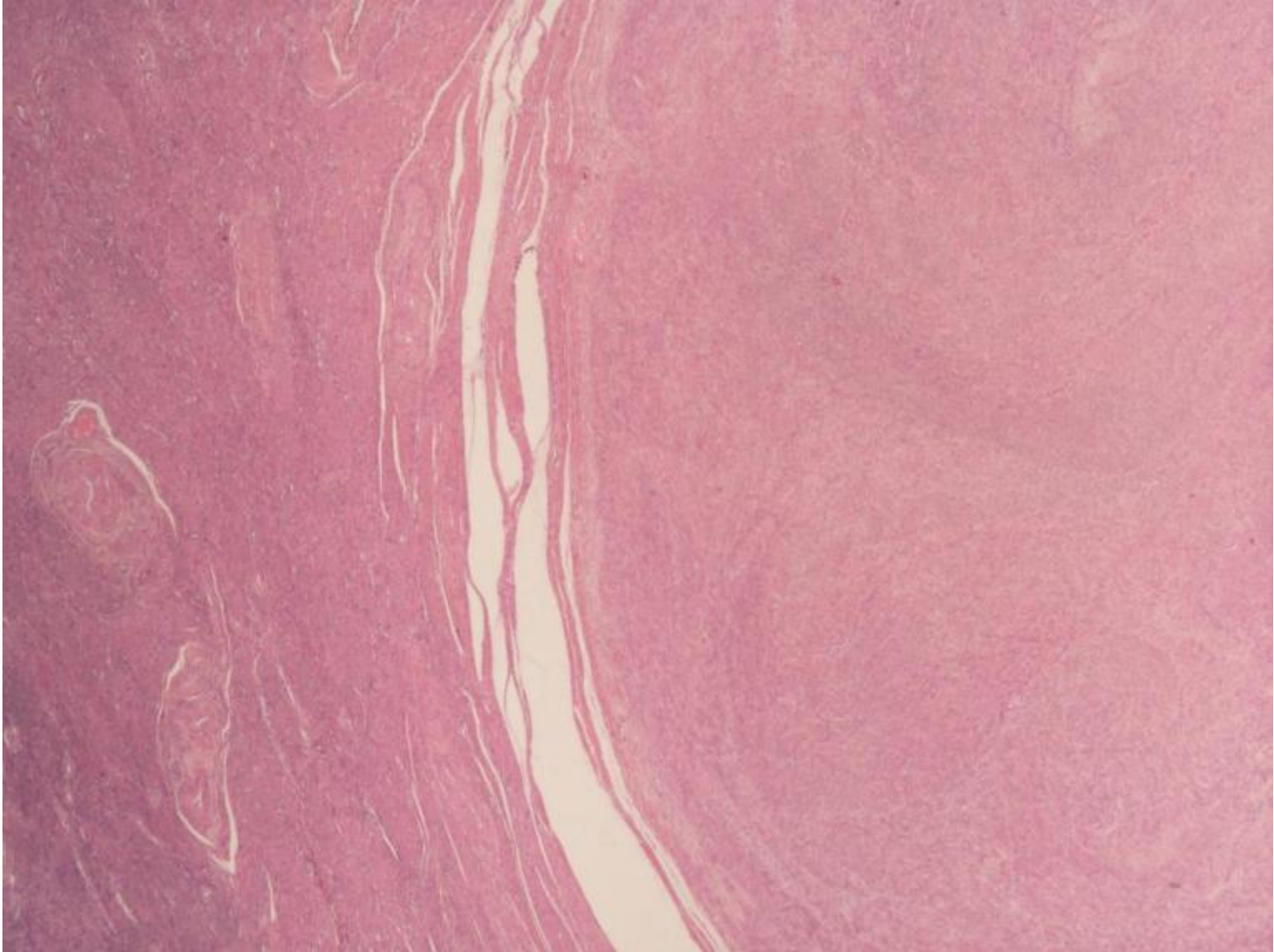
Traitements chirurgicaux possibles:

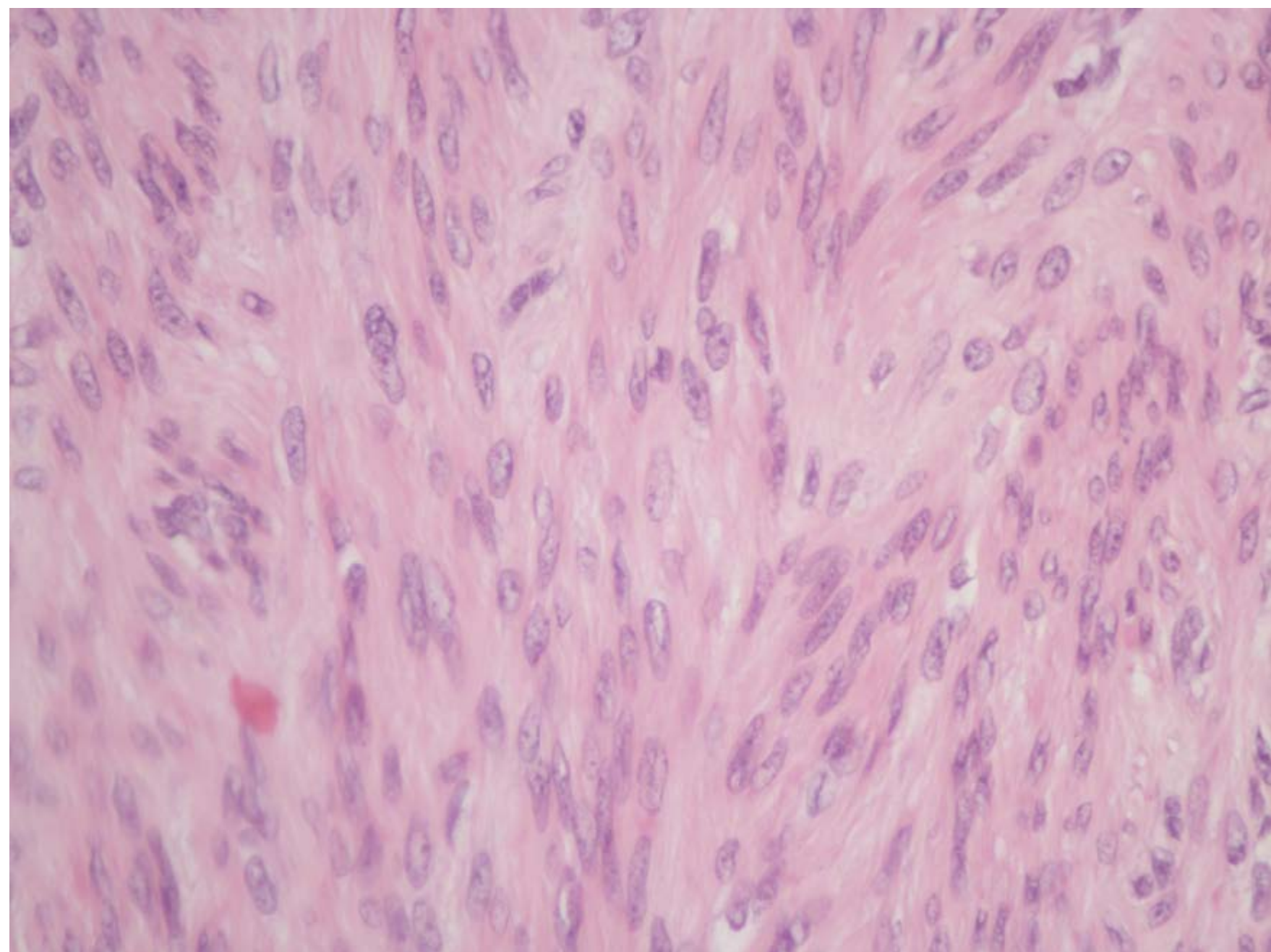
- Curetage endométrial mais souvent efficacité limitée dans le temps.
- Thermocoagulation endométriale.
- Résection endométriale hystéroscopique.
- Hystérectomie totale conservatrice après vérification endométriale.
- La polomyomectomie n'est envisagée qu'en cas d'indication particulière (femme jeune souhaitant préserver sa fertilité...).

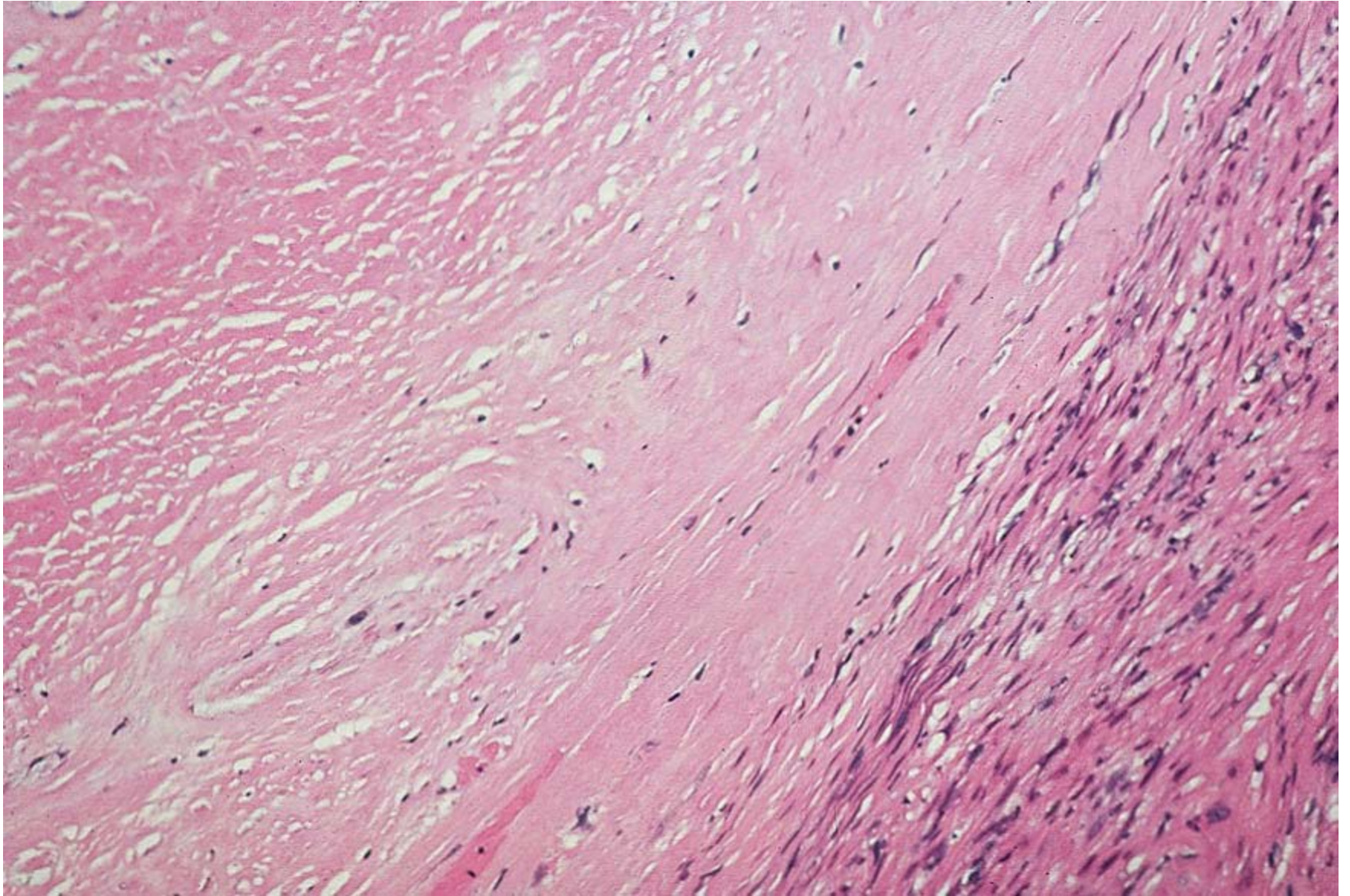
La patiente bénéficie d'une
hystérectomie.



L'aspect anatomopathologique de la pièce opératoire est celui-ci:







Question 10:

Quels aspects anatomopathologiques sont présents sur cette pièce opératoire ?

1. Aspect macroscopique malin
2. Faisceaux fusiformes entrecroisés
3. Cellules allongées non atypiques
4. Remaniements fibro-hyalins
5. Nombreuses mitoses

Aspect typique de fibrome utérin
bénin.

Vignette clinique N°3

Une femme de 71 ans, sans antécédent personnel ou familial notables, mère de deux enfants, ménopausée à l'âge de 52 ans, consulte pour de vagues douleurs abdominales. L'examen clinique met en évidence une probable ascite libre sans tumeur abdominale perçue.

Le col est sain, le frottis cervical est normal. Au toucher vaginal, l'utérus est de petite taille sans particularités, et on note l'existence d'une masse annexielle gauche, irrégulière et fixée.

Question 1

- Quel examen demandez-vous prioritairement en urgence ?
 1. Une colposcopie.
 2. Un US abdominal et pelvien.
 3. Une IRM pelvienne.
 4. Une formule sanguine.
 5. Un scanner hépatique.

Vignette clinique N°3

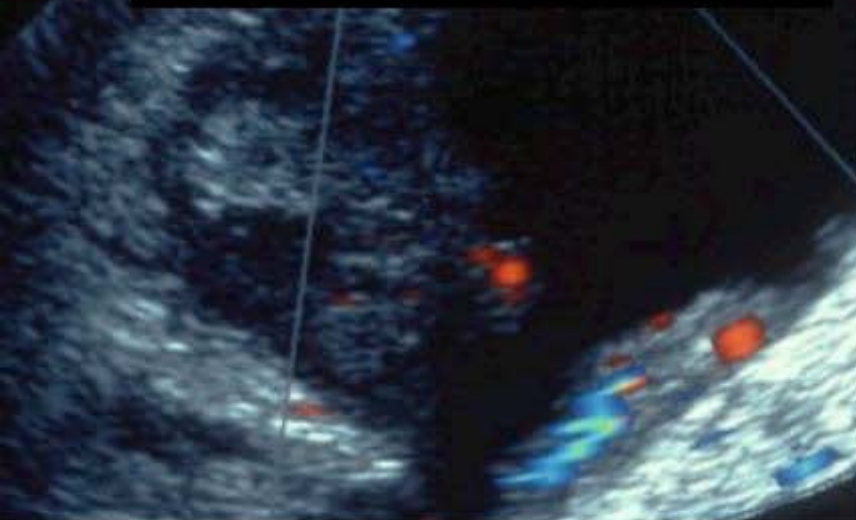
A l'US, il s'agit d'une masse de 8 cm à contenu mixte (mi solide, mi liquide) avec vascularisation Doppler anormal sur les zones solides.

L'hypothèse diagnostique est celle d'une tumeur maligne de l'ovaire.

Question 2

- Quels sont les arguments en faveur de ce diagnostic ?
 1. La présence d'une ascite.
 2. L'existence d'une masse annexielle fixée.
 3. La taille de la masse annexielle.
 4. L'aspect hétérogène de la masse en US.
 5. La vascularisation anormale de la masse.

■ présence d'ascite



■ au moins 4 papillarités

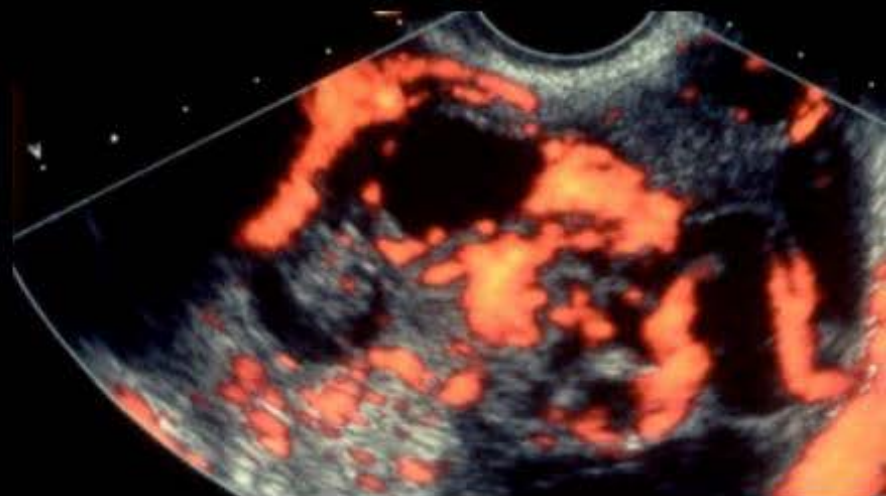


Règles simples pour
malignité

■ tumeur irreg. multi cloisonné-
solide diamètre max. $\geq 100\text{mm}$



■ tumeur solide irrégulière



■ score colorim. très fort (score 4)

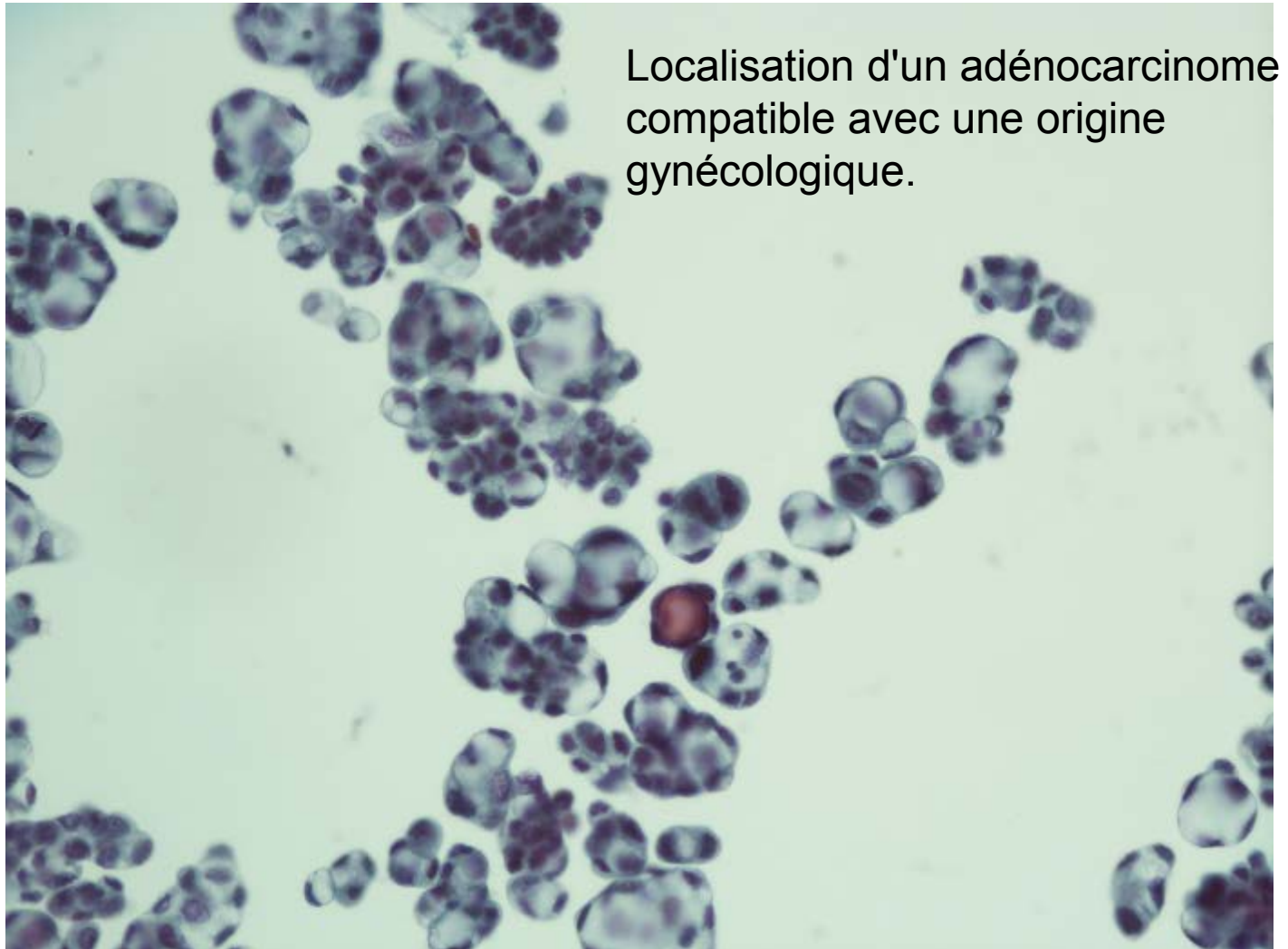
Question 3

- Quels sont les examens paracliniques que vous préconisez ?
 1. Scanner thoraco-abdomino-pelvien.
 2. Gastro – colonoscopie.
 3. Dosage des marqueurs tumoraux (CA125, CA19/9, CEA).
 4. Ponction d'ascite avec étude cytologique.
 5. Biopsie endométriale.

Examens paracliniques des cancers ovariens

- 1) cytologie de ponction (ascite)
- 2) marqueurs (**CA 125**, CA 19-9, He4, bHCG, alphafoetoprot) : élevés 9 fois / 10, mais faux positifs fréquents
- 3) imagerie (US, tomomodensitométrie)
 - ◆ tumeurs pelviennes ou pelvi-abdominales : image mi-solide mi-kystique...
 - ◆ ascite, carcinose
- 4) laparoscopie: conclusion fréquente

La cytologie du liquide péritonéal retrouve l'aspect suivant :



Question 4

1. Le type histologique plus fréquemment retrouvé pour ce type de tumeur est le carcinome séreux.
2. Les carcinomes séreux peuvent être de bas grade ou de haut grade nucléaire.
3. Les carcinomes de bas grade répondent très bien à la chimiothérapie.
4. L'origine des carcinomes séreux de haut grade peut être la trompe, l'épithélium de surface de l'ovaire ou le péritoine.

Tumeurs ovariennes épithéliales malignes

- La grande majorité des **cancers** de l'ovaire = des **carcinomes/tumeurs épithéliales malignes**
- Sur 100 carcinomes de l'ovaire :

	(sous-) Types histologiques des carcinomes ovariens
80	Carcinome séreux de haut grade
11	Adénocarcinome endométriode
3	Carcinome mucineux primaire de l'ovaire
3	Carcinome à cellules claires
3	Types rares

Carcinome séreux de haut grade

- Habituellement diagnostiqué à un **stade avancé (III)**
- Facteurs de risque :
 - âge (71 ans),
 - mutation germinale (ou somatique) de BRCA (+ jeune, ca. du sein familial),
 - traitement hormonal de la ménopause: légère majoration du risque
 - Autres causes: amiante, pesticides, talc...
- Rechute et décès fréquents

Scanner abdomino-pelvien.



Le scanner pratiqué retrouve les aspects suivants :

- Pas d'anomalie thoracique.
- Ascite libre d'environ 2500 ml.
- Masse ovarienne gauche de 9 cm de diamètre avec aspect hétérogène hypervascularisé suspect.
- Présence de signes de carcinose avec aspect de gâteau épiploïque et présence d'implants en particulier au contact de la coupole diaphragmatique droite dont les plus gros font plus de 5 cm de diamètre.
- Pas d'adénopathie suspecte.

Question 5

- Quel est le stade FIGO pressenti de cette tumeur au vu des résultats du scanner ?
 1. Stade IC.
 2. Stade IIB.
 3. Stade IIIA.
 4. Stade IIIC.
 5. Stade IVA.

Stadification FIGO 2014

STAGE I: Tumor confined to ovaries			
OLD		NEW	
IA	Tumor limited to 1 ovary, capsule intact, no tumor on surface, negative washings/ascites.	IA	Tumor limited to 1 ovary, capsule intact, no tumor on surface, negative washings.
IB	Tumor involves both ovaries otherwise like IA.	IB	Tumor involves both ovaries otherwise like IA.
IC	Tumor involves 1 or both ovaries with any of the following: capsule rupture, tumor on surface, positive washings/ascites.	<i>IC Tumor limited to 1 or both ovaries</i>	
		IC1	<i>Surgical spill</i>
		IC2	<i>Capsule rupture before surgery or tumor on ovarian surface.</i>
		IC3	<i>Malignant cells in the ascites or peritoneal washings.</i>

Stadification FIGO 2014

STAGE II: Tumor involves 1 or both ovaries with pelvic extension (below the pelvic brim) or primary peritoneal cancer					
OLD			NEW		
IIA	Extension and/or implant on uterus and/or Fallopian tubes		IIA	Extension and/or implant on uterus and/or Fallopian tubes	
IIB	Extension to other pelvic intraperitoneal tissues		IIB	Extension to other pelvic intraperitoneal tissues	
IIC	IIA or IIB with positive washings/ascites.				

*** Old stage IIC has been eliminated***

Stadification FIGO 2014

STAGE III: Tumor involves 1 or both ovaries with cytologically or histologically confirmed spread to the peritoneum outside the pelvis and/or metastasis to the retroperitoneal lymph nodes

OLD		NEW		
IIIA	Microscopic metastasis beyond the pelvis.	<i>IIIA (Positive retroperitoneal lymph nodes and /or microscopic metastasis beyond the pelvis)</i>		
		IIIA1	<i>Positive retroperitoneal lymph nodes only</i>	
		IIIA1(i)	<i>Metastasis ≤ 10 mm</i>	
		IIIA1(ii)	<i>Metastasis > 10 mm</i>	
		IIIA2	<i>Microscopic, extrapelvic (above the brim) peritoneal involvement ± positive retroperitoneal lymph nodes</i>	
IIIB	Macroscopic, extrapelvic, peritoneal metastasis ≤ 2 cm in greatest dimension.	IIIB	<i>Macroscopic, extrapelvic, peritoneal metastasis ≤ 2 cm ± positive retroperitoneal lymph nodes. Includes extension to capsule of liver/spleen.</i>	
IIIC	Macroscopic, extrapelvic, peritoneal metastasis > 2 cm in greatest dimension and/or regional lymph node metastasis.	IIIC	<i>Macroscopic, extrapelvic, peritoneal metastasis > 2 cm ± positive retroperitoneal lymph nodes. Includes extension to capsule of liver/spleen.</i>	

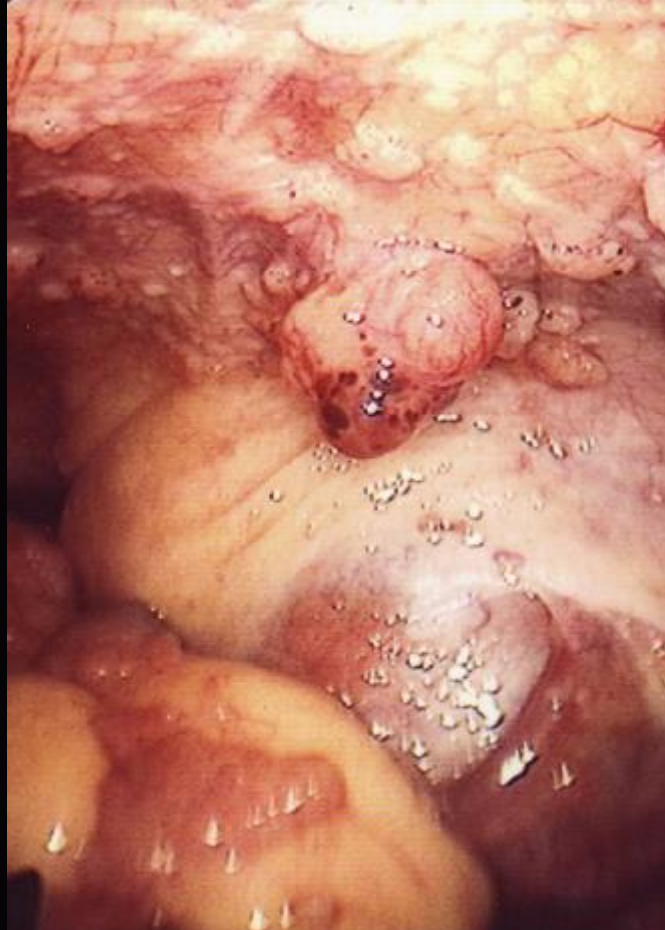
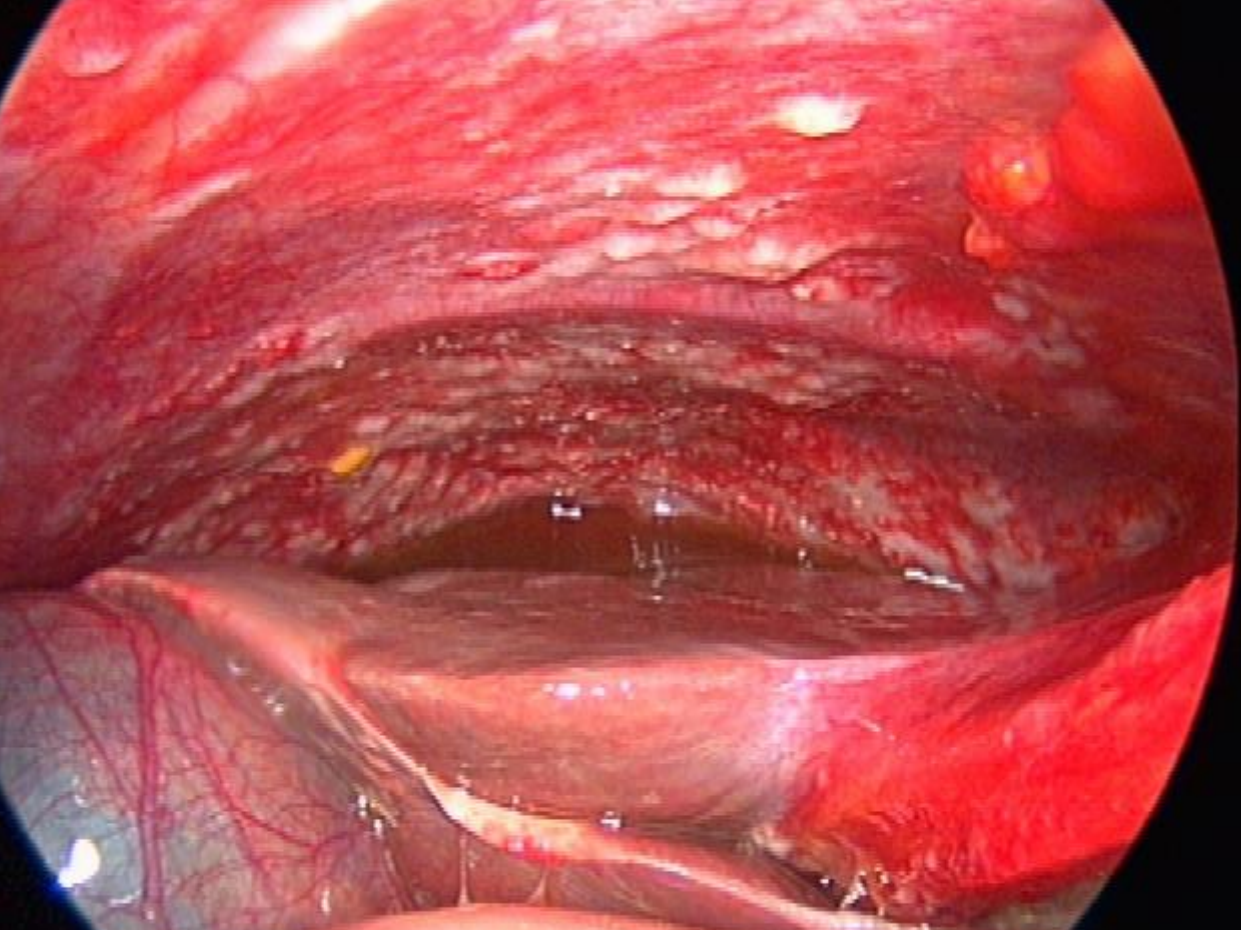
Stadification FIGO 2014

STAGE IV: Distant metastasis excluding peritoneal metastasis				
OLD			NEW	
IV	Distant metastasis excluding peritoneal metastasis. Includes hepatic parenchymal metastasis.		IVA	<i>Pleural effusion with positive cytology</i>
			IVB	Hepatic and/or <i>splenic parenchymal</i> metastasis, metastasis to extra-abdominal organs (including inguinal lymph nodes and lymph nodes outside of the abdominal cavity)

Other major recommendations are as follows:

- Histologic type including grading should be designated at staging
- Primary site (ovary, Fallopian tube or peritoneum) should be designated where possible
- Tumors that may otherwise qualify for stage I but involved with dense adhesions justify upgrading to stage II if tumor cells are histologically proven to be present in the adhesions

- Afin de mieux inventorier les lésions intra-abdominales, on réalise une **laparoscopie** qui découvre
- une tumeur végétante avec ascite,
- métastase à l'ovaire controlatéral
- et granulations sur le mésentère, l'intestin grêle, les 2 coupes diaphragmatiques, le colon gauche
- le sigmoïde est complètement adhérent à la masse ovarienne.



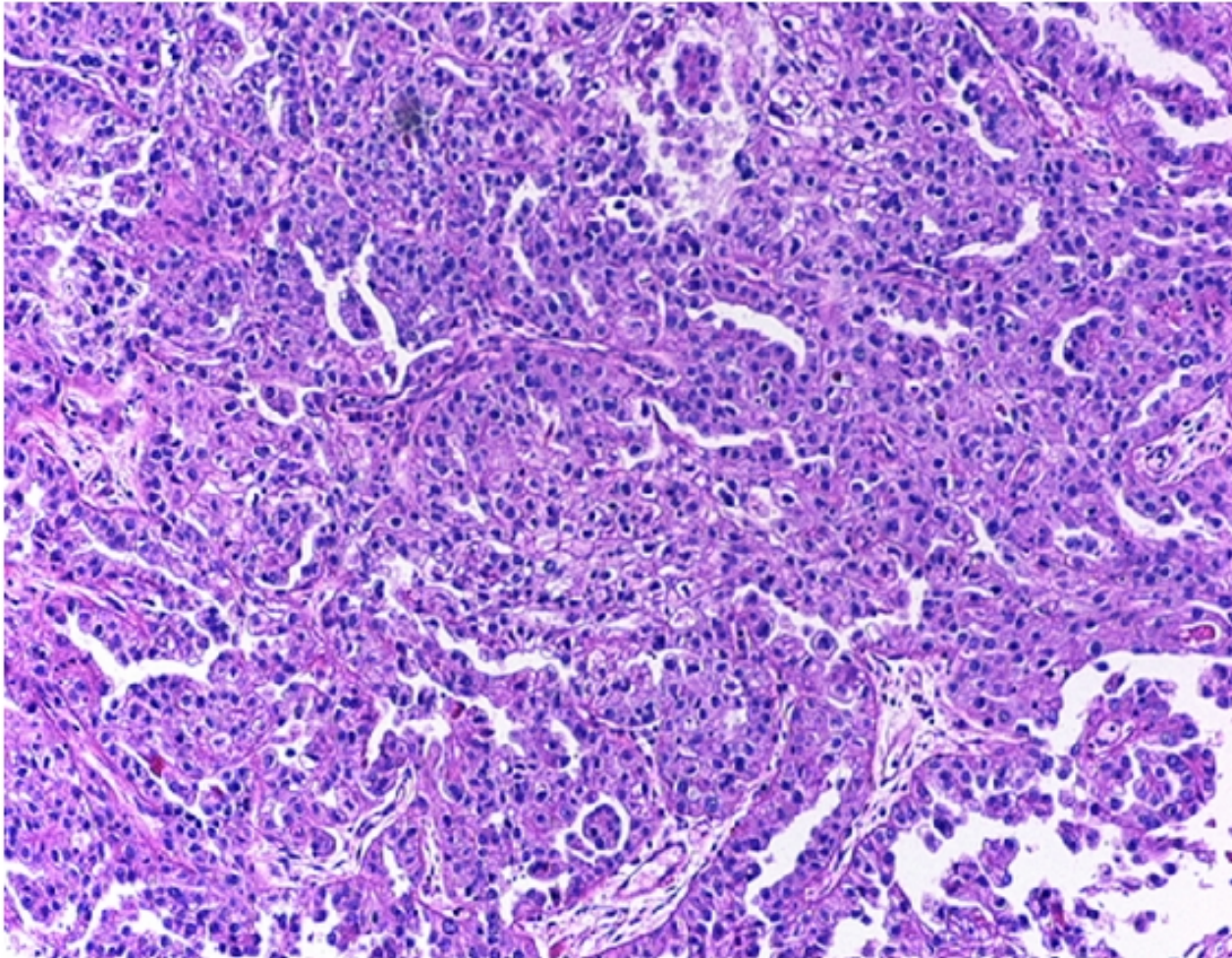
Question 6

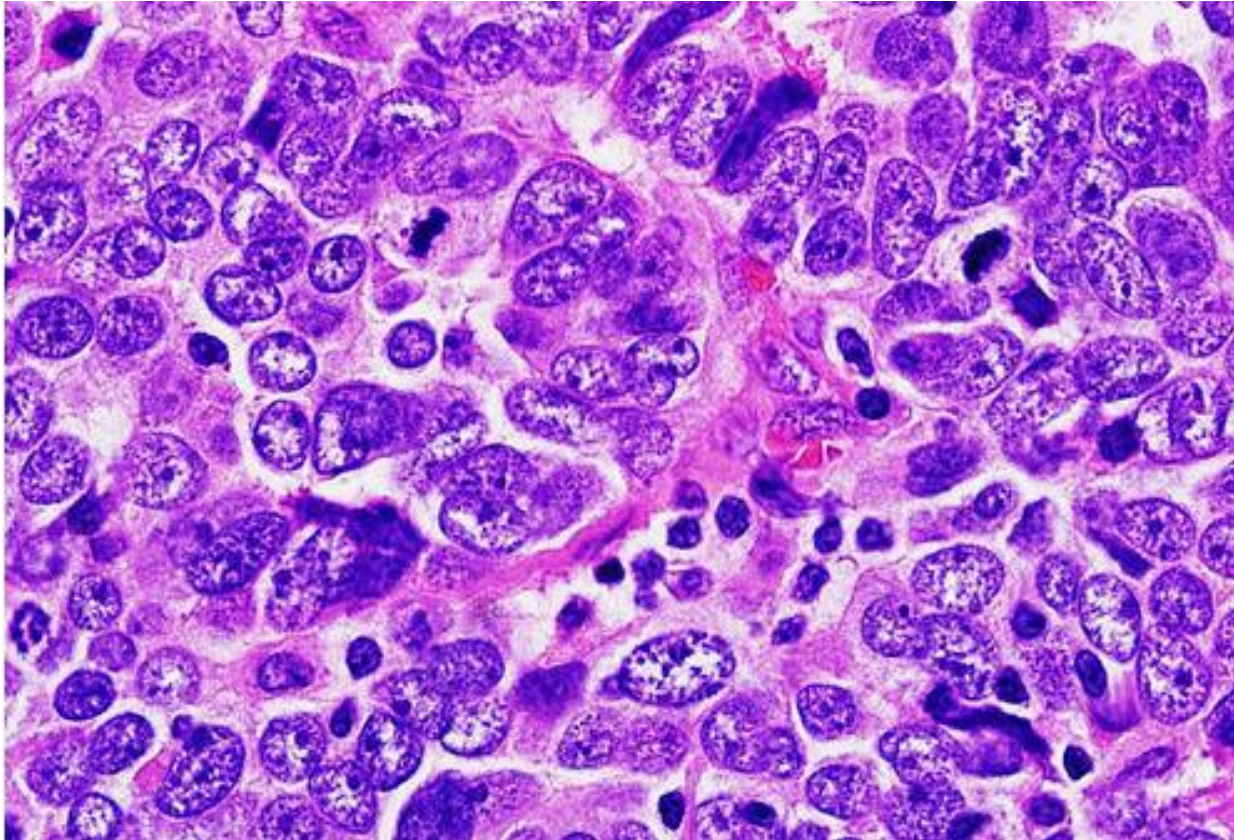
- Quel outil descriptif est utilisé pour établir de manière représentative l'extension de la tumeur ?
 1. Une mensuration de tous les nodules tumoraux.
 2. Le dénombrement de tous les implants tumoraux.
 3. La détermination du PCI (Peritoneal Carcinomatosis Index).
 4. La détermination du plus grand diamètre des 3 plus volumineux nodules tumoraux.
 5. La réalisation du score de Hudson.

Question 7

- Le score de PCI est à 34, avec en particulier des implants étendus du mésentère. Quel est la conduite à tenir ?
1. Ablation des plus gros nodules tumoraux par laparoscopie pour diminuer le volume tumoral.
 2. Passage en laparotomie pour avoir une meilleure détermination du PCI.
 3. Réalisation de biopsies péritonéales diverses sous laparoscopie afin d'avoir des données histologiques précises.
 4. Arrêt de la procédure chirurgicale.
 5. Réalisation d'un staging ganglionnaire complet afin de mieux caractériser le stade FIGO de la lésion.

Les biopsies réalisées retrouvent l'aspect suivant :





Péritoine, implants, biopsies :

- tissu fibreux infiltrés par un **carcinome séreux de haut grade (sur environ 40% de la surface)**, compatible avec une origine gynécologique.

Question 8

- Quel est le stade FIGO de cette tumeur au vu des constatations peropératoires ?

1. Stade IC.
2. Stade IIC.
3. Stade IIIA.
4. Stade IIIC.
5. Stade IVA.

Stadification FIGO 2014

STAGE III: Tumor involves 1 or both ovaries with cytologically or histologically confirmed spread to the peritoneum outside the pelvis and/or metastasis to the retroperitoneal lymph nodes

OLD		NEW		
IIIA	Microscopic metastasis beyond the pelvis.	<i>IIIA (Positive retroperitoneal lymph nodes and /or microscopic metastasis beyond the pelvis)</i>		
		IIIA1	<i>Positive retroperitoneal lymph nodes only</i>	
		IIIA1(i)	<i>Metastasis ≤ 10 mm</i>	
		IIIA1(ii)	<i>Metastasis > 10 mm</i>	
		IIIA2	<i>Microscopic, extrapelvic (above the brim) peritoneal involvement ± positive retroperitoneal lymph nodes</i>	
IIIB	Macroscopic, extrapelvic, peritoneal metastasis ≤ 2 cm in greatest dimension.	IIIB	<i>Macroscopic, extrapelvic, peritoneal metastasis ≤ 2 cm ± positive retroperitoneal lymph nodes. Includes extension to capsule of liver/spleen.</i>	
IIIC	Macroscopic, extrapelvic, peritoneal metastasis > 2 cm in greatest dimension and/or regional lymph node metastasis.	IIIC	<i>Macroscopic, extrapelvic, peritoneal metastasis > 2 cm ± positive retroperitoneal lymph nodes. Includes extension to capsule of liver/spleen.</i>	

Quelle séquence thérapeutique est proposée ?

- Association chirurgie (si possible complète) et chimiothérapie.
- Si tumeur résécable de manière complète (= R0) d'emblée au prix de mutilations non majeures = OK pour la chirurgie première.
- Si risque de chirurgie incomplète ou trop agressive = chirurgie de l'intervalle.

Question 9

- Il est décidé de débiter par une chimiothérapie première.
- Quel type de chimiothérapie est proposée en 1ère intention pour le traitement d'un adénocarcinome séreux annexiel de haut grade ?
 1. Cisplatine - doxorubicine.
 2. Carboplatine – paclitaxel.
 3. Docetaxel – 5FU.
 4. Bléomycine –cisplatine.
 5. Cyclophosphamide – doxorubicine.

Chimio des stades avancés

- La chimiothérapie par Carboplatine + Taxol est depuis longtemps le standard.
- Taux de réponse de l'ordre de 80-90 %.
- A permis de doubler la médiane de survie par rapport aux études historiques.
- Nombre de cures = au moins 6.
- Apport du bévacicumab, des inhibiteurs de PARP (olaparib)...

Question 10

- Quelles autres recommandations thérapeutiques sont conseillées ?
 1. Consultation en radiothérapie en vue d'un traitement de clôture.
 2. Réalisation d'une consultation d'oncogénétique.
 3. Réalisation d'un traitement par anti-aromatase pour 5 ans.
 4. La mise en place d'un drain intra-péritonéal.
 5. Un suivi cardiologique.

Vignette N°3

- La chimiothérapie se déroule assez bien malgré une alopécie complète.
- Après 3 cures de chimiothérapie, un bilan montre une excellente réponse tumorale (normalisation du CA125 et régression des lésions intra-abdominales au scanner).
- Il est donc conseillé la réalisation d'une chirurgie intervallaire.

Question 11

- Parmi les temps chirurgicaux décrits ci-dessous lesquels doivent être pratiqués pour la réalisation d'une chirurgie optimale de l'intervalle.
 1. Omentectomie.
 2. Curage inguinal.
 3. Hystérectomie non conservatrice.
 4. Ablation ou destruction de tous les implants tumoraux visibles.
 5. Appendicectomie.

Les résultats de l'examen histologique définitif des pièces opératoires réséquées sont les suivants :

- Volume de la tumeur
- Remaniements fibreux et inflammatoires

Rapport type de pathologie :

Diagnostic :

1) Hystérectomie totale et annexectomie bilatérale :

Annexes :

- ovaires droit et gauche :
 - remaniement fibreux et inflammatoires focale (10%) et calcifications dystrophiques, sans cellules tumorales ;
- trompe utérine droite et gauche :
 - absence d'infiltration tumorale et de remaniements fibreux et quelques résidus d'adénocarcinome de haut grade.

Utérus :

- polype bénin de l'endomètre et muqueuse endométriale d'aspect atrophique ;
- plusieurs foyers d'adénomyose ;
- absence de carcinome

2-3) Mésentère, biopsies :

- tissu fibro-adipeux avec remaniements fibro-inflammatoires, sans cellules tumorales

4) Omentectomie :

- Tissu adipeux avec foyers de fibrose et inflammation chronique macrophagique, avec quelques cellules tumorales.

5-6) Péritoine (espace de Morisson) et coupole diaphragmatique droite, biopsies :

- tissu avec remaniement fibreux et inflammatoire, sans tumeur.

Question 11

- A la fin de l'intervention il n'existait plus de résidu tumoral détectable (résection R0). Quelle conduite à tenir ultérieure préconisez-vous ?
1. Arrêt des traitements et surveillance.
 2. Reprise de la même chimiothérapie pour 3 cures complémentaires.
 3. Addition de 3 cures de chimiothérapie intrapéritonéale.
 4. Changement de type de chimiothérapie avec réalisation de 6 cures de chimiothérapie adjuvante.
 5. Réalisation d'une laparoscopie de « second look » 4 mois plus tard.

Question 12

- Quelles sont les chances de survie à 5 ans de la patiente ?

1. $> 80 \%$.
2. 65% .
3. 45%
4. 25%
5. $< 15 \%$.

Vignette clinique N°4

Mme C., 31 ans, primigeste nullipare (1 IG chirurgicale), présente une cytologie cervicale anormale. Son précédent frottis réalisé il y à 4 ans lors de son IG, était normal.

La patiente a comme antécédent notable

- une appendicectomie à l'âge de 11 ans,
- une salpingite traitée à l'âge de 16 ans,
- Un fibro-adénome du sein droit opéré à l'âge de 24 ans.

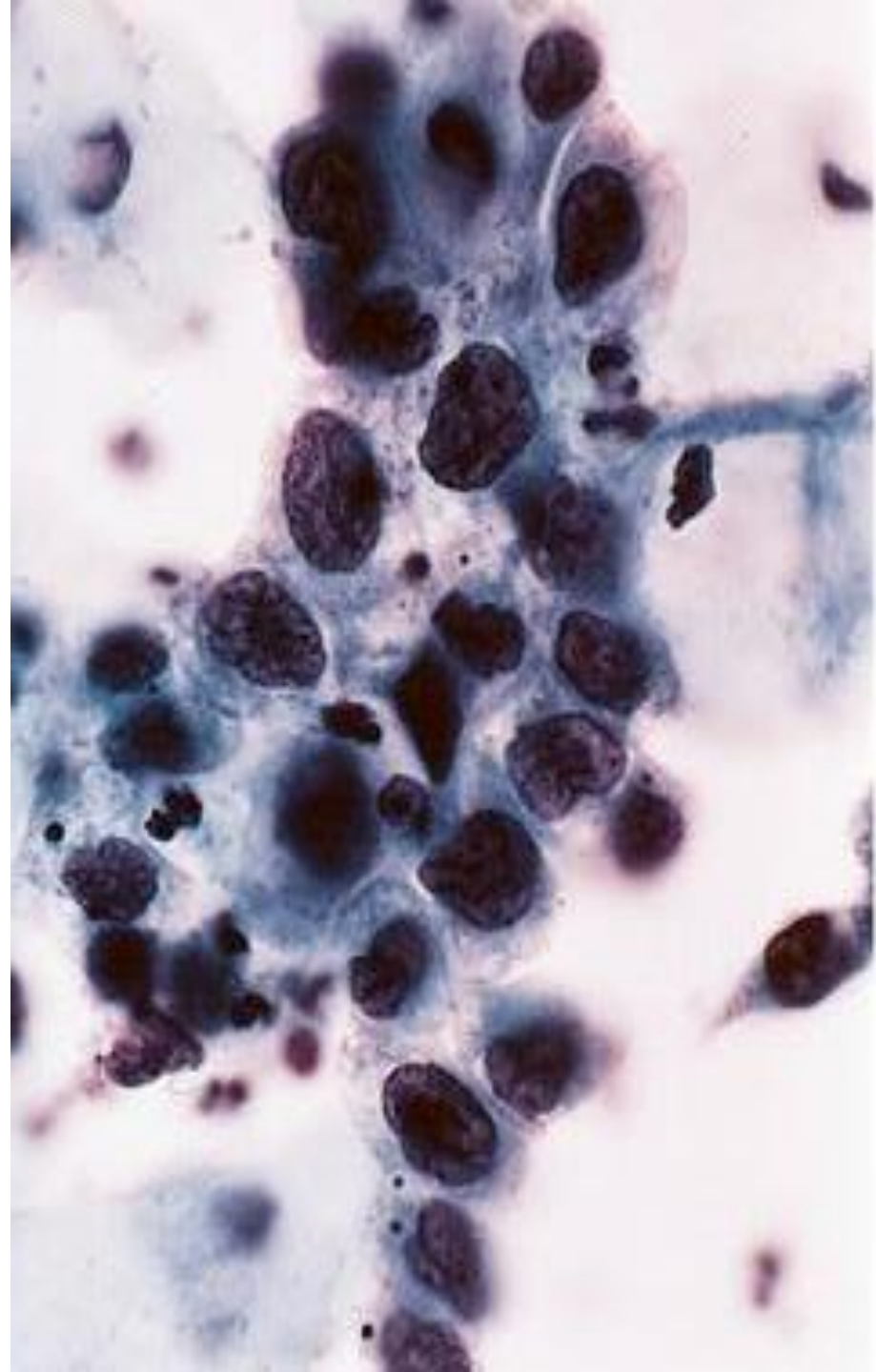
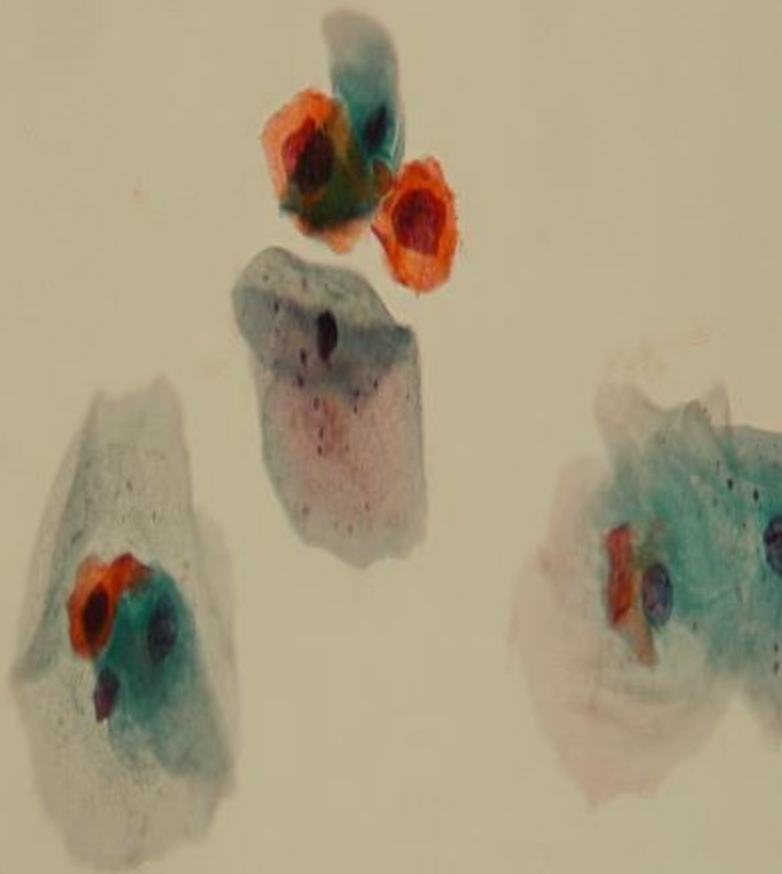
Vignette clinique N°4

Malgré vos conseils Mme C. fume 10-12 cig/jour.

Elle n'a pas de plaintes et bénéficie d'une contraception par Cérazette (progestatif faiblement dosé en continu) du fait de son tabagisme.

A l'examen visuel, le col utérin paraît normal, le reste de l'examen est sans anomalie.

Photo 1:
cytologie évocatrice
d'une lésion de haut grade



Question 1: Quelle est la fréquence conseillée des cytologies cervicales de dépistage chez une patiente sans antécédent particulier ?

1. Annuelle.
2. Tous les 2 à 3 ans.
3. Tous les 5 ans.
4. A partir de 50 ans.
5. Jusqu'à 80 ans.

Dépistage cytologique dans la population générale

- Frottis cervical tous les 3 ans (après 2 FCU normaux à 1 an d'intervalle).
- A partir de 20-25 ans.
- Jusqu'à 70 ans.

Question 2: Quel est l'agent causal des dysplasies cervicales ?

1. L'herpès virus de type 2.
2. Le tabagisme.
3. Le papilloma virus humain (HPV) dit à haut risque.
4. Le papilloma virus humain (HPV) dit à bas risque.
5. Les agressions du col utérin (dilatation, accouchement...).

Etats pré-cancéreux du col

- Dénommés aussi dysplasies CIN...
- Sont essentiellement liés à l'évolution d'une infection à HPV.
- Précèdent le cancer épidermoïde du col.
- Mais leur régression spontanée n'est pas rare.
- Sont dépistés par le frottis cervical (FCU).

Épidémiologie des cancers : force d'association

RR

> 500 HPV 18 et adénocarcinome cervical aux Philippines
HPV 16 et cancer du col au Costa Rica
HPV et cancer du col à Bangkok

100 VHB et cancer du foie à Taiwan

50 VHB et cancer du foie en Grèce

20 VHC et cancer du foie en Italie

10 Cigarettes et cancer du poumon

1 ⇒ ----- NIVEAU DE REFERENCE -----

0,1 Arrêt du tabac (< 50 ans) et cancer du poumon

0,1 Vaccination HB des nouveau-nés et cancer du foie à Taiwan

0,6 Vaccination HB des adultes et cancer du foie en Corée

Question 3: Quels sont les facteurs de risque de dysplasie cervicale présentés par Mme C. ?

1. Son tabagisme.
2. Sa nulliparité.
3. L'utilisation de Cérazette.
4. L'antécédent de salpingite.
5. Le traumatisme du col utérin (IG chir.).

Facteurs de risque des dysplasies et du cancer du col utérin

- Bas niveau socio-économique
- Sexualité:
 - ◆ précocité du 1er rapport sexuel
 - ◆ nombre de partenaires sexuels (surtout du partenaire)
- Multiparité.
- Tabagisme.
- Carence en vitamine A.
- Absence de dépistage
- Infections génitales dont **infection par HPV**

Question 4: Quels examens paracliniques peuvent vous aider au diagnostic chez Mme C.?

1. Une colposcopie.
2. Une recherche virale sur le col utérin.
3. Des biopsies du col utérin avec étude histologique.
4. Une prise de sang pour dosage des marqueurs tumoraux.
5. Une échographie du col utérin.

Vous réalisez une colposcopie qui retrouve l'image ci-dessous:

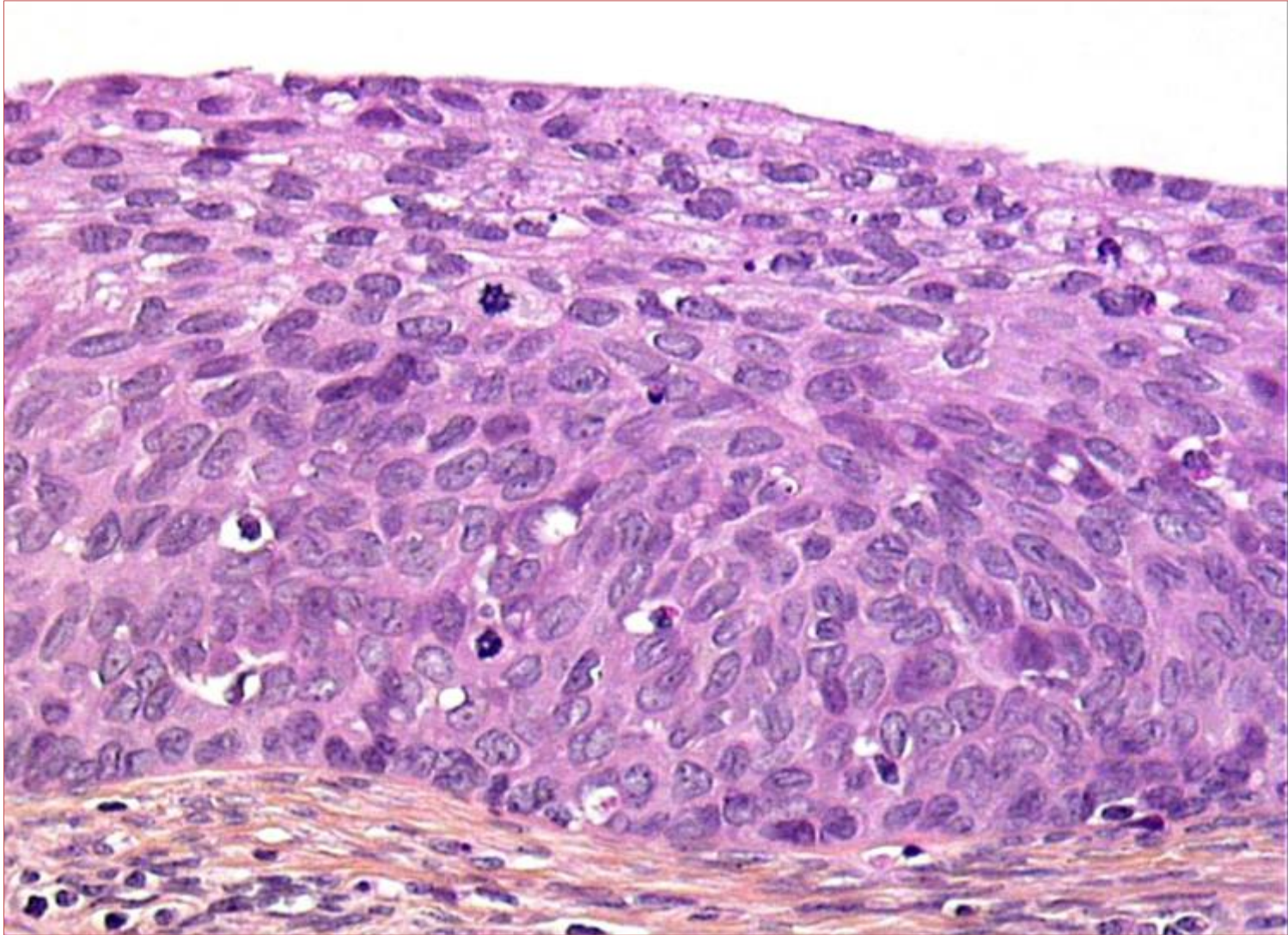


La colposcopie:

L'intérêt principal de la colposcopie : guide la biopsie. Cependant il existe des:

- faux positifs : biopsies "inutiles"
- faux négatifs :
 - ◆ 0 si jonction cylindro-pavimenteuse vue
 - ◆ proche de 100 % si jonction non vue

Etude histologique de la biopsie:



Question 5: Quels types d'anomalie histologique sont présents sur cette biopsie:

1. Nombreuses mitoses
2. Modifications de type réactionnel
3. Noyaux irréguliers, augmentés de taille
4. Perte de la maturation de l'épithélium
5. Inflammation intra-épithéliale

Question 5: Quels types d'anomalie histologique sont présents sur cette biopsie:

1. Nombreuses mitoses
2. Modifications de type réactionnel
3. Noyaux irréguliers, augmentés de taille
4. Perte de la maturation de l'épithélium
5. Inflammation intra-épithéliale

Rapport ana-path

Col utérin, 12h, biopsie :

Epithelium de la zone de jonction avec :

- lésion intra-épithéliale de haut grade (HSIL / CIN3)**

Question 6:

Quel est le risque évolutif de cette lésion en l'absence de traitement ?

1. Disparition des lésions dans 80% des cas dans un délai de 3 ans.
2. Passage à une lésion de bas grade dans 50% des cas dans un délai de 5 ans.
3. Risque de métastases à distance dans 30% des cas dans un délai de 3 ans.
4. Risque de 30-40% d'apparition d'un cancer invasif du col utérin dans un délai de 10 ans.
5. Stabilité des lésions dans 90% des cas sur un délai d'au moins 5 ans.

Question 7:

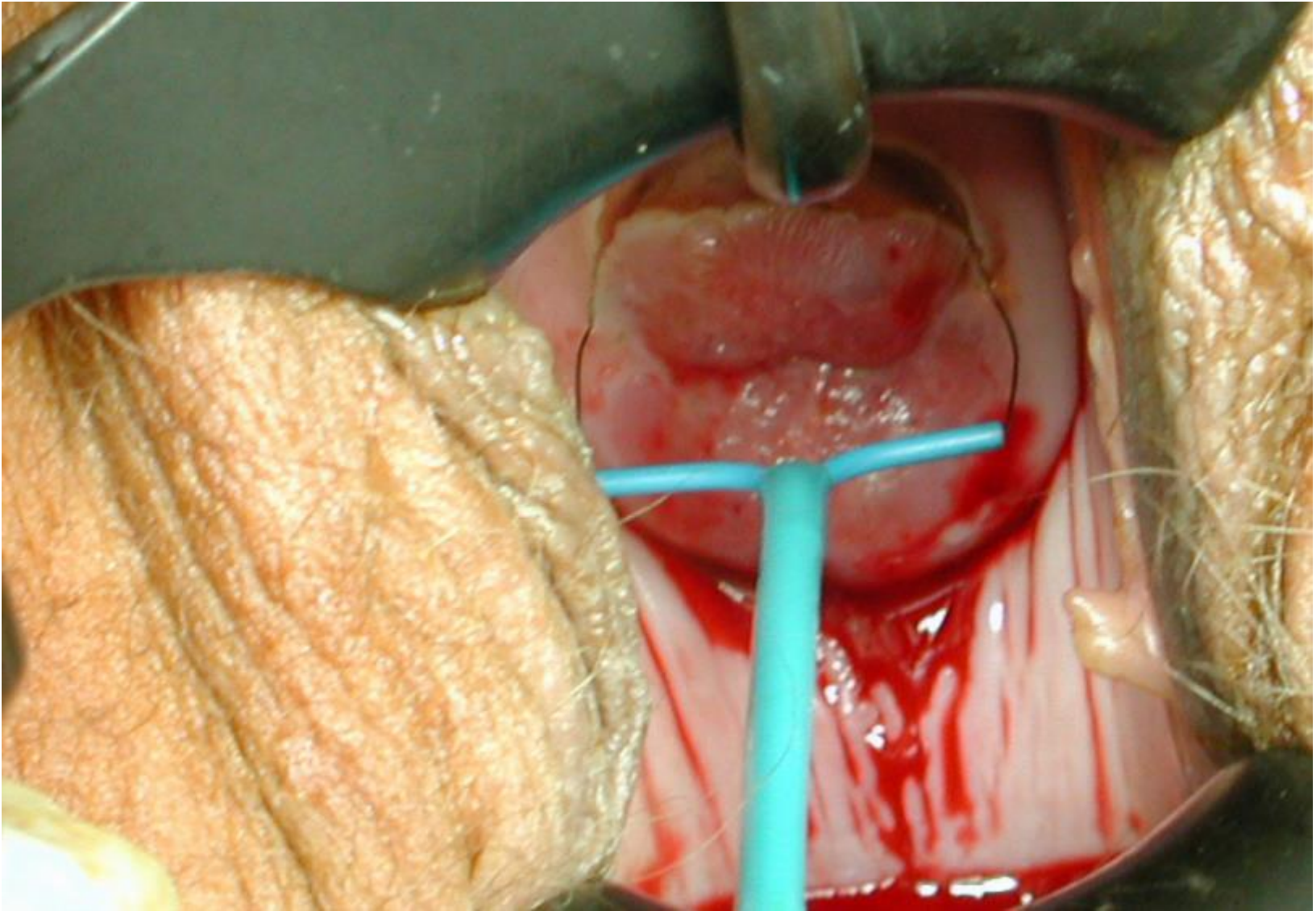
Quelle modalité thérapeutique proposez-vous ?

1. Une destruction par laser de la lésion.
2. Une vaccination HPV.
3. Une conisation.
4. Une hystérectomie.
5. Un contrôle cytologique à 6 mois.

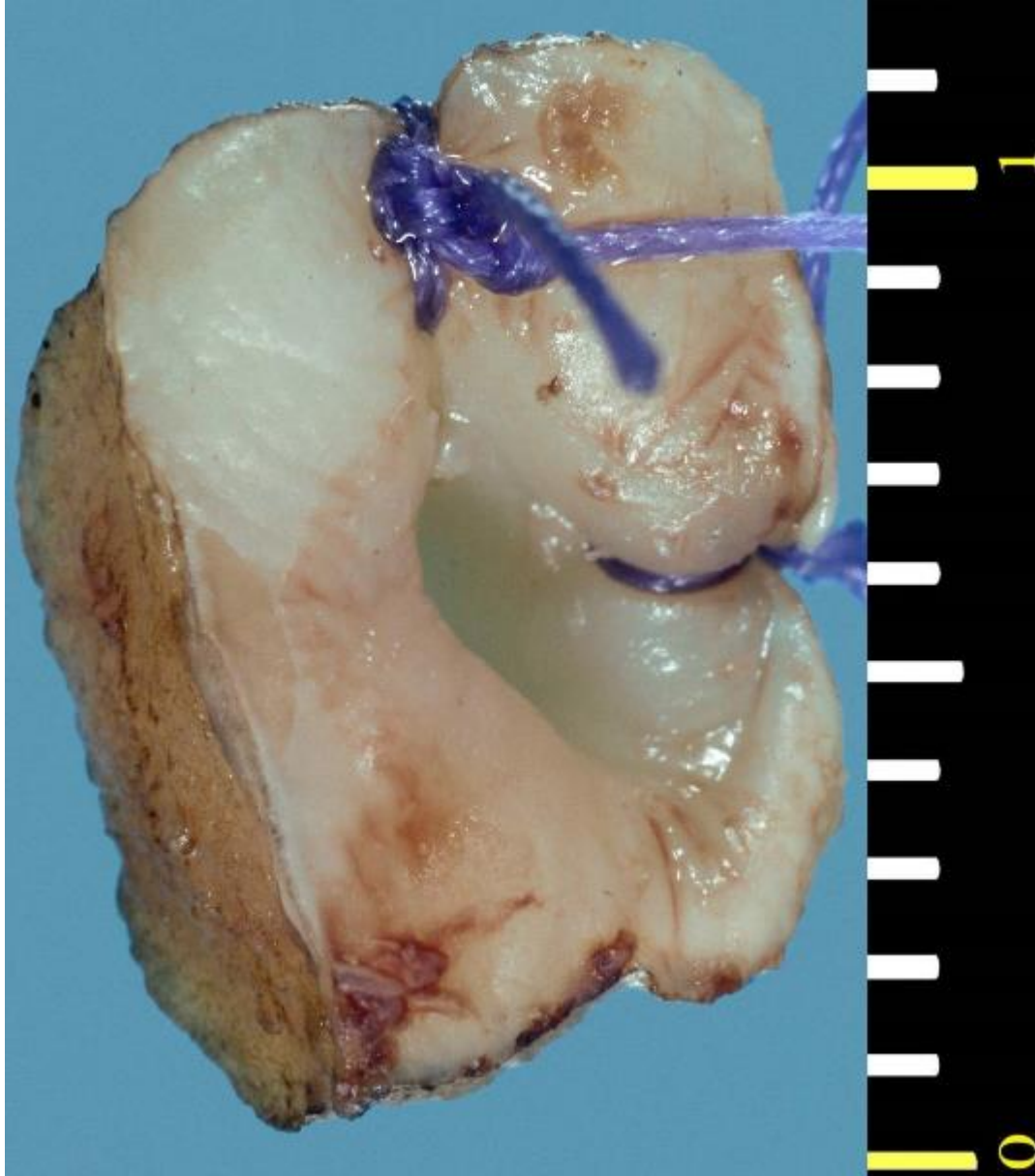
Traitement = conisation

- technique chirurgicale :
 - ◆ bistouri froid: peu utilisé
 - ◆ anse diathermique: privilégié
- technique anatomopathologique :
 - ◆ orientation de la pièce
 - ◆ coupes semi-sérialées

**Vous faites réaliser une conisation
à l'anse diathermique.**



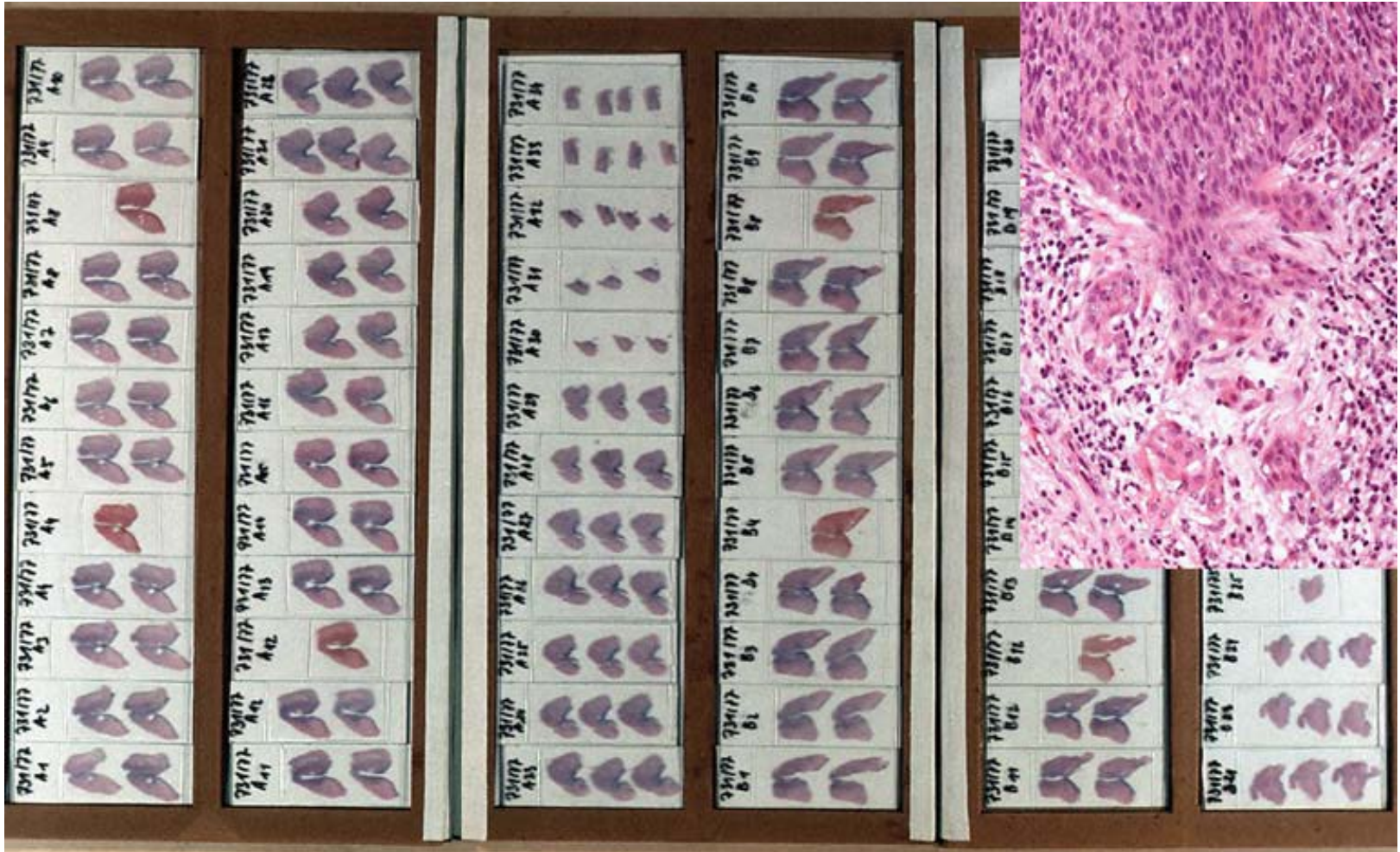
Conisation



Le pathologiste:

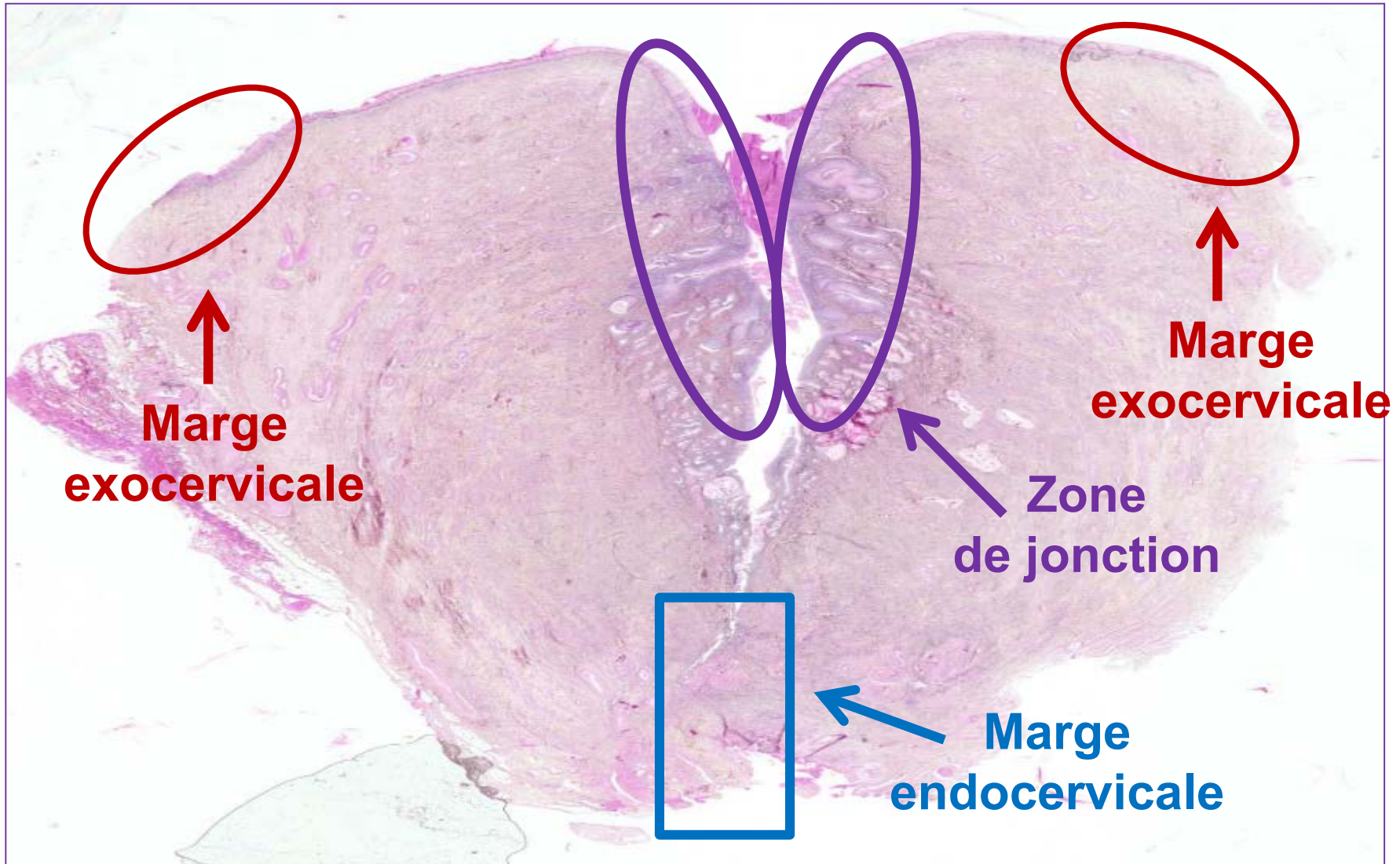
- Inclut toute la pièce en blocs
- Vérifie l'absence de carcinome invasif
- et l'état de la tranche de section chirurgicale.

Conisation



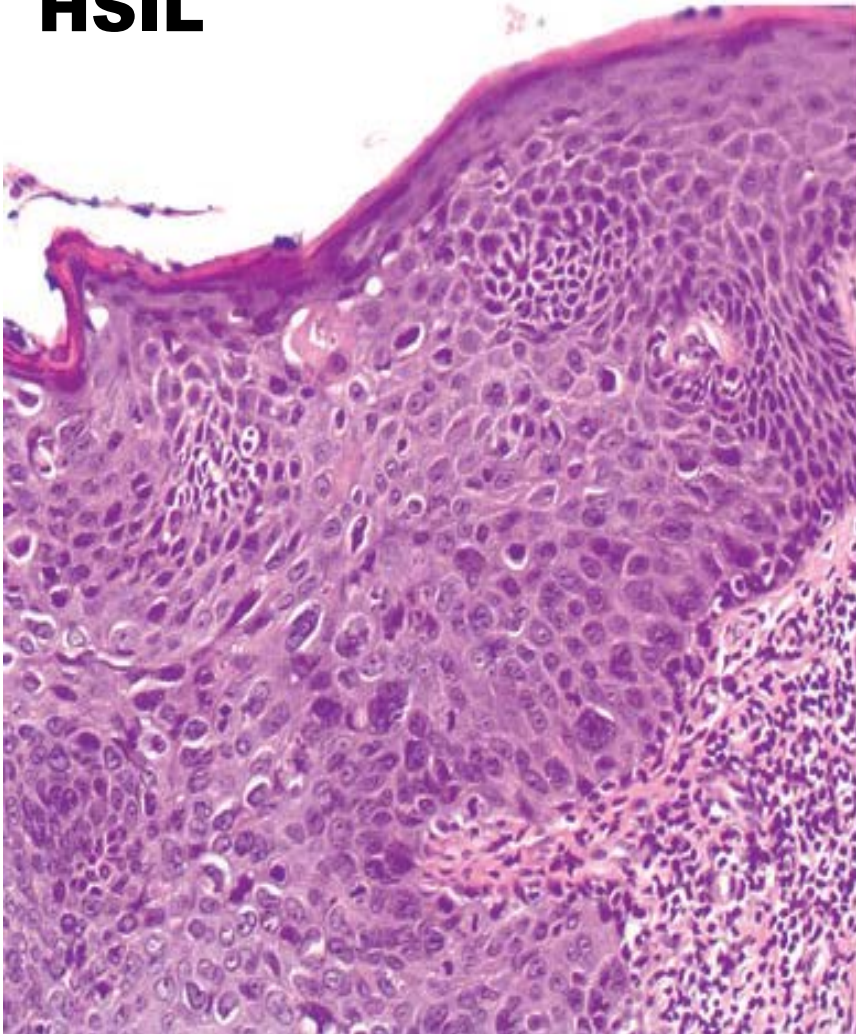
Le pathologiste regarde de nombreuses coupes

L'histologie de la pièce opératoire:

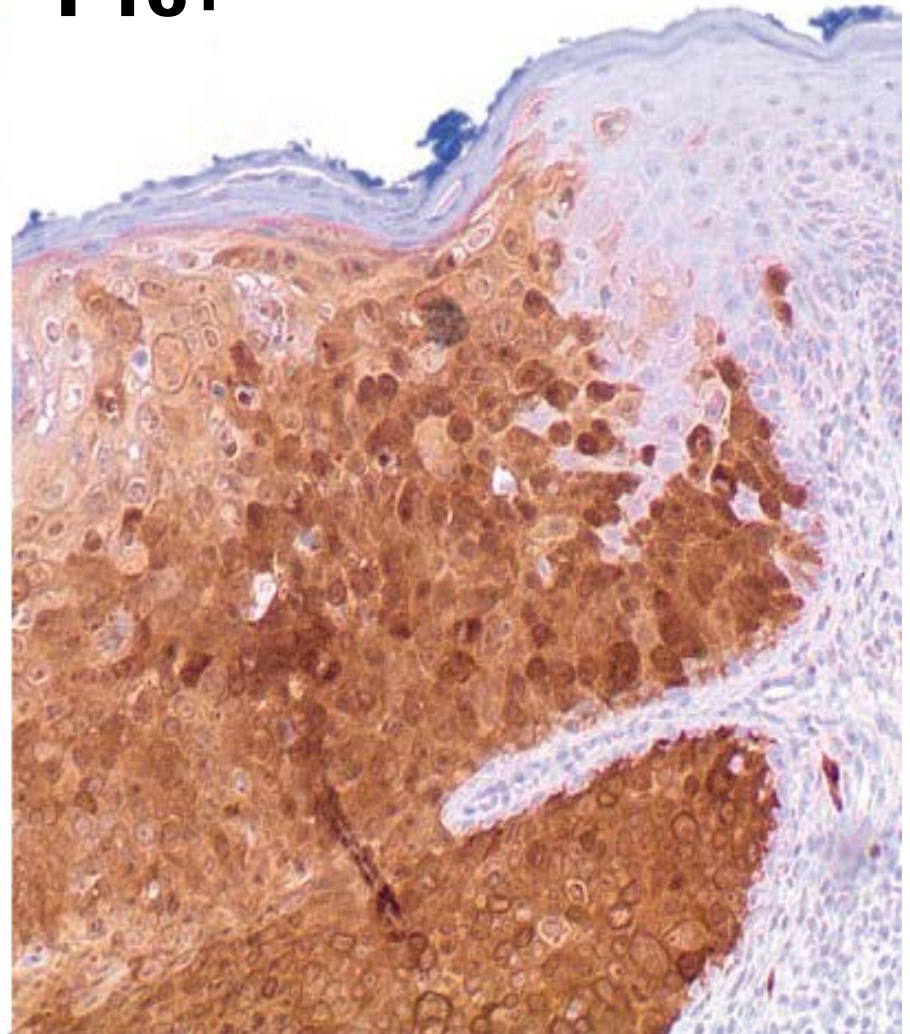


Zone de jonction

HSIL



P16+



Rapport ana-path

Col utérin, conisation :

Muqueuse de la zone de jonction avec :

- **lésion intra-épithéliale de haut grade (HSIL / CIN3).**
- Absence de carcinome invasif.
- Marges chirurgicales :
 - endocervical : sans lésion
 - exocervical : sans lésion

Question 8:

Quelle(s) surveillance(s) ultérieure(s) envisagez-vous, et à quel rythme ?

1. Un premier contrôle cytologique à 6 mois.
2. Un premier contrôle cytologique à 2 ans.
3. Une surveillance colposcopique tous les 3 mois.
4. Une recherche d'HPV à haut risque à 6 mois.
5. Des biopsies de contrôle à 1 an.

Suivi après traitement

La surveillance ultérieure dépendra des résultats histologiques définitifs de la pièce de résection du col. En cas de confirmation du diagnostic de lésion de haut grade:

- Un contrôle cytologique et colposcopique sera réalisé à 6 mois, à 1 an, à 18 mois puis tous les ans.
- Il est actuellement proposé de réaliser un test du papillomavirus humain 6 mois après le traitement. Si ce test est négatif, on pourra réaliser une surveillance cytologique habituelle (tous les 2 – 3 ans).